BADANIE FIZYKALNE W PIELĘGNIARSTWIE

PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE

Redakcja naukowa
Danuta Dyk

PZWL

BADANIE FIZYKALNE W PIELĘGNIARSTWIE

PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE

BADANIE FIZYKALNE W PIELĘGNIARSTWIE

PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE

Redakcja naukowa

Danuta Dyk

PZWL

© Copyright by PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2020

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.

Autorzy i Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, aby wybór i dawkowanie leków w tym opracowaniu były zgodne z aktualnymi wskazaniami i praktyką kliniczną. Mimo to, ze względu na stan wiedzy, zmiany regulacji prawnych i nieprzerwany napływ nowych wyników badań dotyczących podstawowych i niepożądanych działań leków, Czytelnik musi brać pod uwagę informacje zawarte w ulotce dołączonej do każdego opakowania, aby nie przeoczyć ewentualnych zmian we wskazaniach i dawkowaniu. Dotyczy to także specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku nowych lub rzadko stosowanych substancji.

Wydawca: *Anna Plewa*
Redaktor prowadzący: *Barbara Nowak-Pacholczak*
Redaktor merytoryczny: *Anna Klocek*
Producent: *Monika Dąbrowska*

Projekt okładki i stron tytułowych: *Kalina Możdżyńska* / www.woksbykalina

Wydanie II zmienione i uzupełnione
Warszawa 2020

ISBN 978-83-200-6007-2

PZWL Wydawnictwo Lekarskie
02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2
tel. 22 695 43 21
www.pzwl.pl
www.nursing.com.pl

Księgarnia wysyłkowa:
tel. 42 680 44 88; infolinia: 801 33 33 88
e-mail: wysylkowa@pzwl.pl

Skład i łamanie: IT WORKS / itworks.net.pl
Druk i oprawa: OSDW Azymut Sp. z o.o., ul. Senatorska 31, 93-192 Łódź

Informacje w sprawie współpracy reklamowej: reklama@pwn.pl

AUTORZY

Dr n. med., mgr piel. Edyta K. Cudak
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki,
Katedra Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. n. med., mgr piel. Danuta Dyk
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki,
Katedra Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. n. o zdr., mgr piel. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT,
Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr n. med., mgr piel. Aleksandra Gutysz-Wojnicka
Katedra Pielęgniarstwa, Szkoła Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr n. med. Marek Krzemiński
Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Dr n. med., mgr piel. Bożena Nowaczyk
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki,
Katedra Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr hab. n. o zdr., dr n. med., mgr piel. Danuta Zarzycka
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

PRZEDMOWA

Od czasu transformacji kształcenia zawodowego pielęgniarek badania fizykalne stały się moim głównym wyzwaniem dydaktycznym. Ocena stanu pacjenta w oparciu o wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego to podstawowe kwalifikacje absolwenta kierunku pielęgniarstwo, a jednocześnie pierwszy i kluczowy etap procesu opieki.

Doświadczenia związane z przyjęciem pierwszego wydania podręcznika *Badania fizykalne dla pielęgniarek* i wzrastające oczekiwania w stosunku do kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie skłoniły nas do rozbudowania aktualnej wersji książki o dwa rozdziały. Jeden z nich zawiera treści dotyczące odrębności badania podmiotowego i przedmiotowego osoby w wieku geriatrycznym, drugi – jak uzyskane wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego dokumentować i zastosować do oceny sytuacji zdrowotnej pacjenta.

Wersja zaktualizowana podręcznika zawiera zatem 16 rozdziałów, zredagowanych według tej samej struktury. Każdy z nich obejmuje elementarne zagadnienia dotyczące anatomii, zasad i sposobu badania oraz dokumentację wyników w ujęciu tabelarycznym. W dokumentacji wyników badania podmiotowego i przedmiotowego na tle cech prawidłowych uwzględnione zostały objawy chorobowe w obrębie układu czy narządu.

Opracowanie przeznaczone jest głównie dla studentów kierunku pielęgniarstwa, ale z powodzeniem może też służyć innym zawodom medycznym i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom edukacyjnym w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że nowe wydanie podręcznika ułatwi przyswajanie wiedzy i umiejętności kompleksowej oceny stanu zdrowia pacjentów. Świadomość wykorzystania tych kwalifikacji jest ciągle niewystarczająca – zarówno wśród pielęgniarek, jak i pracodawców. Wierzymy, że opracowanie to okaże się przydatne do pobudzenia zainteresowania tym niezwykle istotnym etapem świadczeń medycznych.

Danuta Dyk

SPIS TREŚCI

1. OCENA STANU ZDROWIA – Aleksandra Gutysz-Wojnicka **15**

1.1. Uwarunkowania kulturowe i społeczne 15

1.2. Uwarunkowania spowodowane płcią, rasą i wiekiem badanego 20

2. BADANIE PODMIOTOWE – Danuta Dyk, Edyta K. Cudak **23**

2.1. Zasady przeprowadzania badania podmiotowego 23

2.2. Sposób badania 26

2.3. Wywiad dotyczący aktualnego stanu zdrowia 28

2.4. Wywiad dotyczący dolegliwości ze strony narządów i układów 30

2.5. Wywiad rodzinny i środowiskowy 32

3. PODSTAWY BADANIA PRZEDMIOTOWEGO – Danuta Dyk **35**

3.1. Podstawy anatomii topograficznej 35

3.2. Metody i ogólne zasady badania przedmiotowego 40

3.3. Badanie przedmiotowe ogólne i dokumentowanie wyników 44

3.3.1. Wygląd zewnętrzny – pierwsze wrażenie 44

3.3.2. Budowa i proporcje ciała, wzrost i stan odżywienia 45

3.3.3. Podstawowe parametry życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi, temperatura ciała) 48

4. BADANIE SKÓRY, PRZYDATKÓW SKÓRY I WĘZŁÓW CHŁONNYCH – Danuta Dyk **57**

4.1. Badanie skóry i dokumentowanie wyników 57

4.1.1. Badanie włosów i dokumentowanie wyników 62

4.1.2. Badanie paznokci i dokumentowanie wyników 63

4.2. Badanie węzłów chłonnych i dokumentowanie wyników 66

5. BADANIE GŁOWY I SZYI – Edyta K. Cudak **73**
5.1. Badanie głowy 74
5.1.1. Badanie narządu wzroku 75
5.1.2. Badanie ucha 83
5.1.3. Badanie nosa i zatok 86
5.1.4. Badanie jamy ustnej i gardła 90
5.1.5. Badanie ślinianki przyusznej 94
5.2. Badanie struktur szyi 94
5.2.1. Badanie gruczołu tarczowego 95
5.2.2. Badanie tchawicy 98

6. OCENA KLATKI PIERSIOWEJ I GRUCZOŁÓW PIERSIOWYCH – Danuta Dyk **99**
6.1. Struktury anatomiczne klatki piersiowej, linie topograficzne 99
6.2. Kształt i symetria klatki piersiowej 103
6.3. Badanie gruczołów piersiowych i dokumentowanie wyników badania 106

7. OCENA CZYNNOŚCI ODDECHOWEJ – Danuta Dyk **113**
7.1. Wprowadzenie 113
7.2. Badanie przedmiotowe klatki piersiowej 115
7.2.1. Oglądanie 115
7.2.2. Badanie palpacyjne 116
7.2.3. Opukiwanie 119
7.2.4. Osłuchiwanie 121
7.3. Dokumentowanie wyników 124

8. BADANIE UKŁADU KRĄŻENIA – Danuta Dyk **129**
8.1. Badanie serca 130
8.2. Ocena krążenia tętniczego 137
8.2.1. Badanie tętna tętniczego 137
8.2.2. Ocena ukrwienia tętniczego ręki (test Allena) 142
8.2.3. Badanie krążenia włośniczkowego – nawrót kapilarny 143
8.3. Ocena krążenia żylnego 143
8.3.1. Ciśnienie i tętnienie w żyłach szyjnych 143

9. BADANIE BRZUCHA – Danuta Dyk **151**
9.1. Wprowadzenie 151
9.2. Badanie przedmiotowe brzucha 152
9.2.1. Oglądanie 153
9.2.2. Osłuchiwanie 154
9.2.3. Opukiwanie 155
9.2.4. Badanie palpacyjne 157
9.3. Badanie odbytu 163
9.4. Dokumentacja wyników badania 165

10. BADANIE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
– Aleksandra Gaworska-Krzemińska **167**
10.1. Budowa żeńskiego układu płciowego 167
10.2. Ocena dojrzałości płciowej 170
10.3. Prowadzenie badania 173
10.4. Dokumentacja wyników badania 179

11. BADANIE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH
– Aleksandra Gaworska-Krzemińska **183**
11.1. Budowa męskiego układu płciowego 183
11.2. Ocena dojrzałości płciowej 185
11.3. Badanie okolicy pachwinowej, prącia, moszny, jądra i powrózka nasiennego 187
11.4. Badanie palpacyjne okolicy okołoodbytniczej i gruczołu krokowego 189
11.5. Dokumentacja wyników badania 191

12. BADANIE UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO
– Aleksandra Gaworska-Krzemińska, Marek Krzemiński **197**
12.1. Schemat badania 197
12.1.1. Ogólny stan układu narządu ruchu 197
12.1.2. Odcinkowy stan układu narządu ruchu 200
12.1.3. Miejscowy stan układu narządu ruchu 201
12.2. Badanie poszczególnych elementów układu mięśniowo-szkieletowego 205
12.2.1. Badanie stawu skroniowo-żuchwowego 206
12.2.2. Badanie kręgosłupa 207
12.2.3. Badanie kończyny górnej 213

12.2.4. Badanie miednicy 221
12.2.5. Badanie kończyny dolnej 223
12.3. Dokumentacja wyników badania 230

13. ELEMENTY BADANIA NEUROLOGICZNEGO
– Aleksandra Gutysz-Wojnicka **237**
13.1. Wprowadzenie i cel 237
13.2. Zasady i sposoby dokumentowania wyników badania 238
13.3. Ocena stanu psychicznego 239
13.4. Ocena nerwów czaszkowych 247
13.4.1. I nerw czaszkowy (nerw węchowy) 247
13.4.2. II nerw czaszkowy (nerw wzrokowy) 248
13.4.3. III nerw czaszkowy (nerw okoruchowy), IV nerw czaszkowy (nerw bloczkowy), VI nerw czaszkowy (nerw odwodzący) 248
13.4.4. V nerw czaszkowy (nerw trójdzielny) 249
13.4.5. VII nerw czaszkowy (nerw twarzowy) 251
13.4.6. VIII nerw czaszkowy (nerw przedsionkowo-ślimakowy) 252
13.4.7. IX nerw czaszkowy (nerw językowo-gardłowy) i X nerw czaszkowy (nerw błędny) 252
13.4.8. XI nerw czaszkowy (rdzeniowy) (nerw dodatkowy) 253
13.4.9. XII nerw czaszkowy (nerw podjęzykowy) 254
13.5. Badanie układu ruchu 257
13.6. Badanie czucia 262
13.6.1. Czucie głębokie 266
13.6.2. Czucie powierzchowne 267
13.6.3. Interpretacja bodźców czuciowych – funkcja płata ciemieniowego 268
13.7. Ocena równowagi i koordynacji ruchowej (zborności) 270
13.8. Badanie odruchów 272
13.9. Badanie objawów oponowych 280

14. BADANIE DZIECKA Z UWZGLĘDNIENIEM ODRĘBNOŚCI FIZYCZNYCH I PSYCHOMOTORYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z WIEKIEM
– Edyta K. Cudak **283**
14.1. Badanie podmiotowe 283
14.2. Badanie przedmiotowe 284
14.2.1. Ocena ogólnego stanu zdrowia 284

14.2.2. Badanie skóry i jej przydatków 287
14.2.3. Badanie węzłów chłonnych 289
14.2.4. Badanie układu kostno-stawowego 290
14.2.5. Badanie głowy i szyi 292
14.2.6. Badanie narządów zmysłów oraz jamy ustnej i gardła 293
14.2.7. Badanie układu oddechowego 297
14.2.8. Badanie układu krążenia 300
14.2.9. Badanie jamy brzusznej 304
14.2.10. Badanie narządów moczowo-płciowych 306
14.2.11. Badanie układu nerwowego 307

15. ODRĘBNOŚCI W BADANIU PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM OSOBY W WIEKU GERIATRYCZNYM – Bożena Nowaczyk **311**
15.1. Badanie podmiotowe 312
15.2. Badanie przedmiotowe 317

16. OCENA STANU ZDROWIA PACJENTA NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA PODMIOTOWEGO I PRZEDMIOTOWEGO – Danuta Zarzycka **331**
16.1. Dokumentowanie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego 332
16.1.1. Zasady dokumentowania opieki pielęgniarskiej 332
16.1.2. Schemat opisu stanu zdrowia pacjenta – SOAP 333
16.1.3. Wybrane skale klinimetryczne do oceny stanu pacjenta 336
16.2. Analiza wyników badania podmiotowego i przedmiotowego na potrzeby oceny stanu zdrowia 352

PYTANIA SPRAWDZAJĄCE 363

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ SPRAWDZAJĄCYCH 367

PYTANIA TESTOWE 383

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ TESTOWYCH 397

SKOROWIDZ 399

1. OCENA STANU ZDROWIA

Aleksandra Gutysz-Wojnicka

WPROWADZENIE I CEL

Badania podmiotowe i przedmiotowe są metodami gromadzenia danych o pacjencie. Zakres danych gromadzonych podczas badania powinien odzwierciedlać całościowe (holistyczne) postrzeganie pacjenta z uwzględnieniem wszystkich sfer jego funkcjonowania (biologicznej, psychicznej, społecznej, kulturowej). Zgodnie z definicją WHO „zdrowie to dobrostan biopsychospołeczny, a nie tylko brak choroby czy niepełnej sprawności", aby więc ocena stanu zdrowia pacjenta była pełna i miarodajna, niezbędne jest uwzględnienie w czasie badania specyficznych dla niego uwarunkowań kulturowych, społecznych, psychicznych, związanych z jego płcią, wiekiem i rasą. Przeprowadzenie oceny stanu zdrowia stwarza możliwość poznania pacjenta, jego unikalnej istoty, wewnętrznego bogactwa, niepowtarzalności, odmienności. Uświadamia jednocześnie oczywisty fakt, że ludzie się różnią wykształceniem, sytuacją społeczną i materialną, religią, uznawanymi wartościami, zwyczajami i przekonaniami, kolorem skóry, przynależnością do grupy etnicznej. Zmienne te kształtują specyficzny dla danego człowieka sposób rozumienia zdrowia i choroby, stan wiedzy na temat chorób, ich przyczyn, objawów, postaw wobec choroby, a także wpływają na zachowania zdrowotne. Osoba dokonująca oceny stanu zdrowia zobowiązana jest w czasie wszelkich kontaktów z pacjentem okazywać „bezwarunkową akceptację", szacunek i poszanowanie godności człowieka.

Celem rozdziału jest przedstawienie ogólnych zasad prowadzenia oceny stanu zdrowia w sposób zapewniający ochronę tożsamości kulturowej i godności pacjenta.

1.1. UWARUNKOWANIA KULTUROWE I SPOŁECZNE

Pojęcie „kultura" definiowane jest w różny sposób przez przedstawicieli poszczególnych nauk. Madeleine Leininger, twórczyni teorii kulturowej opieki pielęgniarskiej, pod pojęciem tym rozumie zbiór wyuczonych, podzielanych i przekazywanych w grupie społecznej wartości, wierzeń, norm,

zachowań, które narzucają sposób myślenia, podejmowania decyzji i działania jej członków.

Tożsamość kulturowa rozwija się w czasie życia człowieka pod wpływem procesów językowych i socjalizacji. Kultura jest podzielana przez wszystkich przedstawicieli danej grupy kulturowej, chociaż nie wszyscy członkowie zachowują się w identyczny sposób. Kultura jest wynikiem adaptacji grupy do specyficznych środowiskowych oraz technicznych warunków i zmienia się w czasie, jest dynamiczna i się rozwija.

Personel medyczny powinien stale rozwijać swoją wrażliwość kulturową, aby zapewniać pacjentom opiekę zindywidualizowaną i holistyczną. Aby to osiągnąć, należy:

- **dostrzegać różnorodność kulturową ludzi** – Polska jest krajem w miarę jednorodnym kulturowo; wśród grup etnicznych zamieszkujących na terytorium Polski, które zachowały swój język i odrębną tożsamość kulturową, można wyróżnić Kaszubów, Ślązaków, Łemków, Romów; istnieje też różnorodność wyznań religijnych; oprócz większościowej grupy katolików w Polsce mieszkają wyznawcy prawosławia, kościoła ewangelicko-augsburskiego, judaizmu, islamu, świadkowie Jehowy i inni,
- **okazywać szacunek dla człowieka jako niepowtarzalnej biopsychospołecznej indywidualności uwarunkowanej kulturowo** – człowiek jest wartością samą w sobie, bez względu na specyficzne dla niego cechy biologiczne, psychiczne, społeczne czy kulturowe; zasada szacunku dla osoby jest podstawową zasadą etyczną w pracy lekarzy, pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych; przejawia się ona w respektowaniu praw pacjenta, ustanowieniu partnerskich relacji; żadne okoliczności nie mogą zwolnić pracownika medycznego z jej przestrzegania,
- **szanować nieznane** – nieznane budzi lęk i niepewność, działa stresująco, zmusza do wysiłku, poszukiwania informacji, nauki, wymaga czasu i pokonania pewnego trudu; pierwszy kontakt z pacjentem z odrębnego, nieznanego nam kręgu społeczno-kulturowego może się wiązać z niezrozumieniem i niechęcią; budowanie atmosfery zaufania, pełna akceptacja pacjenta, prawidłowe komunikowanie się z nim, okazywanie rzeczywistego zainteresowania i zaangażowania pozwoli osiągnąć zaplanowany cel,
- **poznawać i analizować własne przekonania kulturowe** – system wartości, wierzeń, przekonań i zachowań, w tym zachowań zdrowotnych każdego z nas, kształtuje się w toku życia społecznego, identyfikacji z jakąś społecznością, zmienia się pod wpływem edukacji, nabywania kolejnych

doświadczeń życiowych i zawodowych; warto zastanowić się: „Czym jest dla mnie własne zdrowie? Wartością daną (przez Boga, geny, przypadek) czy stale nabywaną, o którą należy ciągle zabiegać?", „Jak zachowuję się w obliczu choroby (leczę się sama sposobami domowymi, korzystam z metod medycyny alternatywnej, modlę się, natychmiast po wystąpieniu objawów zgłaszam się do lekarza)?", Czym jest cierpienie (złem, które za wszelką cenę należy likwidować, czy przeżyciem, które może wzbogacać człowieka)?",

- akceptować odmienne niż swoje własne podejście do spraw zdrowia i choroby przez pacjenta w granicach obowiązującego prawa,
- modyfikować opiekę zdrowotną tak, aby uwzględnić potrzeby kulturowe pacjenta – potrzeby te mogą być różne, a ich spełnienie bardziej lub mniej trudne; przykłady potrzeb uwarunkowanych kulturowo: pozostawienie łańcuszka z krzyżykiem zawieszonym na szyi (talizmanów) podczas badania fizykalnego, badanie fizykalne wykonywane przez osobę tej samej płci, badanie osłuchowe klatki piersiowej wykonywane przez koszulkę (odmowa rozebrania się, szczególnie w przypadku kobiet muzułmańskich), obecność zaufanej osoby (męża, ojca) podczas badania fizykalnego, brak zgody na badania i zabiegi podczas szabatu (sobota) u ortodoksyjnych żydów, modyfikowanie jakości kontaktu wzrokowego i sposobu przekraczania granic przestrzeni osobistej pacjenta,
- przyjąć, że wartości i przekonania kulturowe człowieka są zinternalizowane i bardzo trudno je zmienić.

Czynniki kulturowo-społeczne uwzględniane podczas oceny stanu zdrowia, mające wpływ na sytuację zdrowotną pacjenta:

- **Rodzina.** Dla większości Polaków jest najważniejszym celem w życiu i warunkuje poczucie satysfakcji życiowej. W Polsce najczęściej spotyka się model rodziny, w którym mąż i żona pracują zawodowo, a żona dodatkowo wykonuje prace związane z domem. Kobieta ma szansę na rozwój i satysfakcję zawodową, co z jednej strony zmniejsza ryzyko wystąpienia u niej depresji, stanów lękowych, ale z drugiej strony bardziej naraża ją na przemęczenie, choroby wywoływane przewlekłym stresem, takie jak choroba wieńcowa serca, choroba wrzodowa żołądka, choroby płuc. Dzieci w takiej rodzinie uczęszczające do żłobka lub przedszkola częściej zapadają na choroby zakaźne i różnego typu infekcje, a jednocześnie mają wcześniej możliwość rozwoju umiejętności społecznych, budowania własnej niezależności. Zupełnie inne problemy mogą się ujawniać w tradycyjnej rodzinie muzułmańskiej.

W większości takich rodzin to mężczyzna podejmuje znaczące decyzje, małżeństwo jest aranżowane przez rodziców (często w obrębie własnych krewnych), kobieta zawiera je w bardzo młodym wieku, oczekuje się od niej częstego rodzenia dzieci, a dodatkowo jej mąż może mieć inne żony, które wraz z nią i ich dziećmi zamieszkują w tym samym domu.

W czasie zbierania danych o pacjencie ważne jest ustalenie, kto z członków rodziny jest autorytetem w kwestii zdrowia i ma decydujący głos przy podejmowaniu tego typu decyzji.

- **Klasa społeczna.** W ujęciu stratyfikacyjnym kryteriami, na podstawie których zalicza się ludzi do poszczególnych klas, są czynniki obiektywne: dochód, wykształcenie, zawód, stanowisko w zawodzie, oraz czynniki subiektywne: szacunek, uznanie, prestiż przyznawany danej pozycji społecznej przez ludzi. Sytuacja materialna człowieka, jego warunki bytowe, liczba i wiek osób wspólnie zamieszkujących, poziom wykształcenia będą determinowały styl życia, a to od stylu życia w największym stopniu zależy zdrowie człowieka. Wykazano, że wraz ze wzrostem wykształcenia zwiększa się częstotliwość wizyt profilaktycznych i leczniczych u lekarza. Wykształcenie warunkuje również w największym stopniu rozwój i przestrzeganie prawidłowych zachowań zdrowotnych oraz sposób korzystania z opieki społecznej. Niższy status społeczno-ekonomiczny wiąże się z wysokim wskaźnikiem palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków, przy jednoczesnych nieskutecznych próbach zrywania z nałogami. Personel medyczny najłatwiej i najefektywniej nawiązuje kontakt z pacjentem o takim samym statusie społeczno-ekonomicznym. Osoby z odmiennych klas społecznych, zarówno tych wyższych, jak i niższych, najczęściej budzą w nas poczucie niechęci i dyskomfortu, irytują (np. bezdomni), dają poczucie nierozumienia wzajemnych oczekiwań. Wymaga to od wszystkich pracowników ochrony zdrowia stałej refleksji i analizy własnych emocji i zachowań.
- **Religia.** Przekonania, zachowania i postawy związane z wyznawaną religią mają bardzo duży wpływ na zdrowie człowieka. Na przykład zakaz używania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych wśród katolików przypuszczalnie może wpływać na występowanie chorób przenoszonych drogą płciową oraz „niechcianych" ciąż. Rytuał obrzezania praktykowany przez Żydów wiąże się z niskim odsetkiem występowania raka prącia u mężczyzn i raka szyjki macicy u kobiet. Natomiast obowiązujący u mormonów całkowity zakaz palenia papierosów i picia alkoholu powiązany jest z niskim odsetkiem występowania u nich chorób nowotworowych. Wyznawana religia i specyficzne rytuały

z nią związane mogą warunkować stosowaną dietę oraz wzorce żywieniowe, a także zasady utrzymania higieny ciała czy przekonania dotyczące kwestii zdrowia, choroby, cierpienia i śmierci.

- **Komunikacja i przestrzeń osobista.** Komunikowanie się to świadomy i celowy proces wymiany informacji między ludźmi. Wyróżnia się dwie podstawowe formy komunikacji: werbalną i pozawerbalną. Obie odgrywają bardzo ważną rolę w ocenie stanu zdrowia i są uwarunkowane kulturowo. Wzajemne zrozumienie przekazywanych informacji zależy głównie od znajomości języka i używanego przez obie strony słownictwa (medyczne, potoczne, slang). W szczególnych sytuacjach niezbędne może być korzystanie z pomocy tłumacza. Komunikacja pozawerbalna to tzw. mowa ciała, kontakt wzrokowy, dotyk, przestrzeń osobista. W niektórych kręgach kulturowych intensywny kontakt wzrokowy i dotyk traktowane są jako naruszenie prywatności. Na przykład w kulturze wschodniej i orientalnej nadmierny kontakt wzrokowy uważany jest za wyraz braku szacunku i powoduje dyskomfort. Każdy człowiek ma **osobistą strefę dystansu**, tj. przestrzeń osobistą, która oddziela go od świata zewnętrznego. Najbardziej chroniona, traktowana jako własność jest strefa intymna, rozciąga się ona 15–45 cm od ciała danego człowieka. Do tej strefy dostęp mają wyłącznie osoby związane uczuciowo z człowiekiem. Następna jest strefa osobista (46–122 cm) utrzymywana podczas kontaktów społecznych i towarzyskich. W tej strefie odbywa się większa część badania fizykalnego. Strefa społeczna (122–330 cm) utrzymywana jest wobec nieznajomych, w niej odbywa się zbieranie wywiadu. Ostatnia strefa to strefa publiczna (ponad 360 cm). Wtargnięcie w cudzą przestrzeń powoduje agresję, wycofanie i niechęć do tego, kto ją naruszył. Poszanowanie przestrzeni osobistej innej osoby budzi jej akceptację i pozytywne nastawienie. Kultura europejska nakazuje utrzymanie odpowiedniego dystansu w kontaktach z innymi, unikanie dotyku i dotykania obcych z wyjątkiem szczególnych sytuacji. W krajach Ameryki Południowej i arabskich akceptuje się bardzo mały dystans przestrzenny i fizyczny (dotykanie, przytrzymywanie za rękę są akceptowane).
- **Grupa etniczna** (etnos). W znaczeniach antropologicznym i społecznym najczęściej definiowana jest jako zbiorowość, która postrzega siebie samą i postrzegana jest przez otaczające zbiorowości jako odrębna i specyficzna ze względu na jedną lub więcej takich cech, jak: kultura (język, gwara, religia, obyczajowość), genealogia (wspólne losy/historia/przodkowie), poczucie posiadania własnego terytorium i praw do niego, odrębność osobowościowa. Dotychczas przeprowadzone badania wskazują, że przynależność do grupy

etnicznej warunkuje sposób pojmowania choroby, reakcję na ból i jego objawianie się. Na przykład Włosi i Żydzi reagują bardzo emocjonalnie na ból, Amerykanie są bardziej powściągliwi w jego okazywaniu, opisują go w sposób konkretny. Włosi mają także mniejszą tolerancję na ból niż Irlandczycy. Przynależność do grupy etnicznej w dużej mierze warunkuje też sposób spędzania wolnego czasu, sposób odżywiania, poszukiwanie alternatywnych metod leczenia w przypadku zachorowania, potrzebę wsparcia duchowego, troskę o środowisko naturalne. W USA przeprowadzono badanie, którego celem było ustalenie, jakie czynniki kulturowe w opinii pacjentów z różnych grup etnicznych mają wpływ na jakość opieki medycznej przez nich otrzymywanej. Czynnikami wymienionymi zgodnie przez przedstawicieli wszystkich trzech badanych grup etnicznych (Afroamerykanie, Latynosi i przedstawiciele rasy białej nie-Latynosi) były odpowiednio: wiedza lekarza i akceptacja medycyny niekonwencjonalnej (17%), dyskryminacja ze względu na rodzaj polisy ubezpieczeniowej (12%), dyskryminacja ze względu na pochodzenie społeczne (9%), przynależność lekarza i pacjenta (lub jej brak) do tej samej grupy etnicznej (8%) – komunikacja, zaufanie, relacje interpersonalne, dyskryminacja ze względu na wiek (4%).

Na podstawie wyników badań sformułowano zalecenia mogące poprawić jakość opieki medycznej „wrażliwej" kulturowo. Zawierają się one w dwóch grupach:

- umiejętności interpersonalne – dbałość o prywatność, szczególnie podczas badania i podejmowania trudnych tematów, ludzkie traktowanie, brak dyskryminacji,
- efektywna komunikacja – słuchanie pacjenta i zrozumiałe wyjaśnianie.

1.2. UWARUNKOWANIA SPOWODOWANE PŁCIĄ, RASĄ I WIEKIEM BADANEGO

PŁEĆ

W świetle przeprowadzonych badań stwierdza się, że mężczyźni chorują rzadziej, ale choroby, które ich dotykają, cechują się większą śmiertelnością (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu). Natomiast choroby, na które najczęściej zapadają kobiety, chociaż występują częściej, nie mają tak poważnych konsekwencji.

W rezultacie kobiety charakteryzuje dłuższy przewidywany czas życia. Podczas oceny stanu zdrowia kobiet należy zwrócić uwagę na specyficzne dla nich choroby, te związane z ciążą, porodem i połogiem, choroby gruczołu piersiowego

(rak), choroby częściej występujące u kobiet (osteoporoza, depresja) oraz choroby inaczej objawiające się u kobiet (choroby serca).

RASA

Już w 1812 roku Cuvier podzielił gatunek ludzki na trzy rasy (odmiany), według kryterium barwy skóry: białą, żółtą i czarną. Jan Czekański uzupełnił ten podział o trzy wtórne odmiany (rasy: śródziemnomorska, armenoidalna, arktyczna), będące krzyżówkami odmian czystych. Rasa traktowana jest obecnie jako pojęcie umowne, ponieważ zachodzi ciągłe biologiczne różnicowanie populacji na skutek przekazywania genów między osobnikami oraz adaptacji do warunków naturalnych środowiska. Pojęcie „rasa" zastępowane jest pojęciem „grupy populacyjne". Osoby danej populacji, oprócz wspólnych cech biologicznych determinowanych genetycznie (kolor skóry, cechy antropomorficzne) mają wspólne cechy kulturowe.

Kolor skóry jest jedną z cech determinujących przebieg oceny stanu zdrowia. Wskazówki istotne przy ocenie stanu skóry pacjenta czarnoskórego:

- Zmiana koloru skóry jest najlepiej widoczna na twardówce, spojówkach, błonie śluzowej jamy ustnej, języku, ustach, płytce paznokciowej, wewnętrznej powierzchni dłoni i stopach.
- Bladość u pacjentów czarnoskórych ujawnia się jako kolor szaropopielaty, a u osób o brunatnym zabarwieniu skóry przybiera odcienie koloru żółtego.
- Żółtaczka u pacjentów czarnoskórych najlepiej zauważalna jest na twardówce w przyśrodkowej części oka lub na podniebieniu twardym.
- Sinica jest trudna do stwierdzenia u pacjentów czarnoskórych. Należy ocenić miejsca o najmniejszej pigmentacji (błona śluzowa jamy ustnej, płytka paznokciowa, powierzchnia wewnętrzna dłoni, stopy).

WIEK

Oceniając stan zdrowia pacjentów w różnych grupach wiekowych, należy mieć na uwadze specyficzne problemy związane z danym wiekiem. Najczęstszymi przyczynami śmierci dzieci w wieku 1–14 lat są wypadki, nowotwory, wady rozwojowe, niewydolność oddechowa. Oceniając stan zdrowia małego dziecka, trzeba zwrócić uwagę na to, czy występują obrażenia nieprzypadkowe, mogące być wynikiem przemocy fizycznej lub psychicznej.

W grupie nastolatków mogą się zdarzać choroby przenoszone drogą płciową, nadużywanie leków, uzależnienia od papierosów, narkotyków, wypadki, próby samobójcze. Wiek średni to zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi.

PIŚMIENNICTWO

1. Grimes J., Iannopollo E.: *Health Assessment in Nursing Practice*. Jones and Bartlett Publishers Inc., Monterey 1986.
2. Majchrowska A.: *Kultura i jej wpływ na życie społeczne*. W: *Elementy socjologii dla pielęgniarek* (red. I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000.
3. Majchrowska A.: *Zachowania zdrowotne – aspekty socjologiczne*. W: *Elementy socjologii dla pielęgniarek* (red. I. Taranowicz, A. Majchrowska, Z. Kawczyńska-Butrym). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000.
4. Napoles-Springer A. i wsp.: *Patients' perceptions of cultural factors affecting the quality of their medical encounters*. Health Exp., 2005, 8, 4–17.
5. Ogryzko-Wiewiórowska M.: *Socjologia medycyny. Wybrane zagadnienia*. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1989.
6. *Quick Reference to Cultural Assessment*. Mosby, St. Louis 1994.

2. BADANIE PODMIOTOWE

Danuta Dyk, Edyta K. Cudak

Wywiad, czyli badanie podmiotowe, stanowi nieodłączny element badania stanu zdrowia. Wywiad określany bywa również anamnezą (gr. *anamnesis*). Dokładnie zebrany wywiad od pacjenta pozwala uzyskać informacje, które umożliwią ocenę stanu zdrowia oraz rozpoznanie zagrożeń i ustalenie prawidłowej diagnozy. Zadaniem rozdziału jest przedstawienie problematyki badania podmiotowego, z ukierunkowaniem na schemat anamnezy i jej kluczowe składowe.

Celem badania podmiotowego jest uzyskanie informacji o pacjencie, o jego dolegliwościach somatycznych, psychicznych, o jego sytuacji rodzinnej, społecznej. Pozwala ono również zrozumieć istotę schorzenia i pomóc choremu w czasie procesu leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji. Badającemu zaś pomaga określić wraz z pacjentem kierunki działania zespołu terapeutycznego i zasad współpracy podczas procesu diagnozowania, leczenia, pielęgnowania i rehabilitacji.

2.1. ZASADY PRZEPROWADZANIA BADANIA PODMIOTOWEGO

Wywiad zazwyczaj jest przeprowadzany przed badaniem przedmiotowym, jednakże wielokrotnie badanie podmiotowe przeplata się z badaniem przedmiotowym i stanowi jego uzupełnienie.

Podczas wywiadu zadawane są w zasadzie pytania:

- **zamknięte** (bardzo często pojawiają się na początku) – z góry oczekuje się odpowiedzi brzmiących „tak", „nie" lub „nie wiem",
- **otwarte** – pozwalają pacjentowi na swobodną wypowiedź dotyczącą przebiegu choroby i doznawanych przez niego objawów, np.: „Proszę opowiedzieć o swojej dolegliwości", „Co Pana/Panią niepokoi w Pana/Pani stanie zdrowia?",
- **pytania mające na celu pogłębienie wypowiedzi pacjenta** (tzw. wyjaśniające, inaczej sondujące).

W trakcie prowadzenia wywiadu można się posługiwać różnymi technikami, takimi jak **parafrazowanie** (pomaga to upewnić się, czy właściwie rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać), **interpretacja**, **konfrontacja** czy **refleksja**.

Możliwości przeprowadzania badania podmiotowego zależą niejednokrotnie od stanu pacjenta. Można z góry zaplanować rozmowę z pacjentem i przygotować się do niej, ale może też nastąpić sytuacja, kiedy istnieje zagrożenie życia

chorego, i wówczas badanie podmiotowe przybiera formę skróconą, a bardzo często uzyskanie informacji od samego chorego bywa trudne lub niemożliwe. Wówczas źródłem informacji będą członkowie rodziny, znajomi bądź świadkowie zdarzenia. Pamiętać należy o szczególnym rodzaju badania, które głównie dotyczy doznań subiektywnych chorego, czyli o badaniu psychiatrycznym wymagającym od badającego znajomości zagadnień psychologii i psychiatrii.

W czasie badania podmiotowego należy:

- zadbać, aby miejsce, w którym odbywać się będzie badanie, nie powodowało skrępowania i dyskomfortu pacjenta,
- wziąć pod uwagę harmonogram dnia pacjenta, co pozwoli mu skupić się na badaniu i nie będzie powodowało przerw, np. na posiłki, zaplanować czas i poświęcić badanej osobie tyle czasu, ile będzie potrzebować,
- na początku przedstawić się i poinformować pacjenta o planowanych wobec niego działaniach,
- siedzieć naprzeciw pacjenta, utrzymywać z nim kontakt wzrokowy, stosować proste gesty, np. kiwanie głową, zadawać pytania, używając języka zrozumiałego dla danej osoby, tak żeby wiedziała, że jest słuchana,
- rozpoczynać wywiad od spraw ogólnych, a następnie kolejno skupiać się na aktualnych dolegliwościach, nie pytać pacjenta o kilka rzeczy w jednym momencie, cenne informacje zapisywać choremu na osobnej kartce,
- wykorzystywać zasady kontaktu terapeutycznego, nie zapominać o zwrotach, które wyrażają empatię.

Istnieją pewne sytuacje, które w znacznej mierze **utrudniają wywiad lub powodują, że jest on specyficzny dla danej grupy pacjentów**.

- **Wiek badanego pacjenta** (dzieci i osoby starsze) – wywiad w tych dwóch grupach wiekowych jest specyficzny. W odniesieniu do dzieci najczęściej źródłem informacji są rodzice lub opiekunowie, ale są nim też dzieci, które rozumieją i potrafią mówić. Często same trafnie umieją nazwać daną dolegliwość, dlatego ich wypowiedzi są także ważne. Badanie podmiotowe osoby w starszym wieku bywa trudne w związku z tym, że pacjent może nie potrafić nazwać dolegliwości lub nie pamiętać wydarzeń. W tym przypadku źródłem informacji może być również członek rodziny bądź opiekun pacjenta.
- **Upośledzenie pamięci** – takie sytuacje dotyczą osób starszych, ale również pacjentów z poważnymi zaburzeniami neurologicznymi spowodowanymi urazem lub organiczną chorobą mózgu. Źródłem informacji będą osoby najbliższe pacjentowi, karty informacyjne z wcześniejszych pobytów w szpitalu i przebiegu leczenia.

- **Pacjent milczący, gadatliwy, lękowy** – u tej grupy pacjentów zebranie wywiadu jest wyzwaniem, ponieważ każdy z nich będzie się skupiał w pewien sposób na sobie i często będzie miał trudności z nazwaniem dolegliwości. Ponadto pacjent milczący, w depresji, nie ma ochoty na odpowiedź, co wymaga od badającego umiejętności nawiązania kontaktu. Z osobą nadmiernie gadatliwą lub z zaburzeniami toku i treści myślenia badający powinien umieć nawiązać kontakt i wysondować jej odpowiedzi.
- **Pacjent uzależniony od narkotyków lub alkoholu** – efekty rozmowy zależą od tego, czy odbywa się ona w czasie, kiedy pacjent jest odurzony lub w stanie upojenia alkoholowego. Sytuacja taka wymaga od badającego cierpliwości i spokoju oraz dobrej oceny zachowania się badanego.
- **Pacjent z deficytami neurologicznymi** – to pacjent, który często nie rozumie zadawanych pytań lub pomimo ich rozumienia nie może powiedzieć o swoich dolegliwościach.
- **Rodzina i przyjaciele** – zdarza się, że nie pozwalają pacjentowi samodzielnie powiedzieć o objawach chorobowych, o tym, co odczuwa, jak zapatruje się na proponowane możliwości postępowania leczniczego, pielęgnacyjnego czy rehabilitacyjnego. To bardzo utrudnia kontakt i uniemożliwia poznanie do końca punktu widzenia chorego oraz uzyskanie jego świadomej zgody na leczenie.
- **Chorzy nieprzytomni** – ta grupa pacjentów jest bardzo niejednorodna pod względem stanu klinicznego. Nie można mówić tutaj o badaniu podmiotowym chorego, w którym źródłem informacji o objawach subiektywnych i o tym, co miało miejsce w jego sytuacji zdrowotnej, jest on sam. Bardzo często źródłem informacji są świadkowie zdarzenia, czy to w miejscu zamieszkania chorego, czy w miejscu publicznym. Niejednokrotnie przypadkowi świadkowie danego zdarzenia nie potrafią odpowiednio opisać tego, co się wydarzyło. Czasami mamy do czynienia z nadmiarem niespójnych, chaotycznie przekazywanych informacji i trzeba wyselekcjonować te, które pozwolą poznać przyczynę stanu.
- **Pacjenci w stanie terminalnym** – jest to grupa chorych, w której prowadzenie wywiadu bywa szczególnie trudne. Świadomość nieuleczalnej choroby i zbliżanie się do schyłku życia bardzo często są przeplatane milczeniem pacjenta. Wymaga to od badającego postawy empatii i zrozumienia dla decyzji i woli chorego. To również niezwykle ważna, ale i trudna sytuacja w kontaktach z jego najbliższymi, których oczekiwania mogą się znacznie różnić od oczekiwań samego pacjenta.

2.2. SPOSÓB BADANIA

Badanie podmiotowe jest procesem zmierzającym nie tylko do wyegzekwowania na drodze pytań informacji o dolegliwościach chorobowych pacjenta. Przede wszystkim pozwala skupić się na badanej osobie i poznać, jak postrzega ona swoją sytuację zdrowotną. Badający powinien spoglądać zarówno z perspektywy procesu chorobowego (analizując dolegliwości, dokonując rozpoznania różnicowego), jak i z perspektywy samego pacjenta (jaką postawę wobec swojej choroby przyjmuje, jakie ma oczekiwania, co go niepokoi, czego się boi, jakie emocje negatywne ten stan wyzwala). Opracowany system badania Calgary–Cambridge oddaje w pełni schemat badania podmiotowego zgodnego z taką właśnie koncepcją.

Według **systemu Calgary–Cambridge** badanie podmiotowe składa się z pięciu głównych punktów:

1. Początek wywiadu, którego podstawowym elementem jest nawiązanie z badanym kontaktu i podjęcie próby określenia tego problemu, który aktualnie występuje.
2. Gromadzenie informacji, w czasie którego należy się skupić na omówieniu problemów chorego oraz starać się poznać i zrozumieć jego zapatrywania na własny problem oraz dokonać systematycznego pogrupowania danych.
3. Kolejnym etapem jest zbudowanie zaufania między badanym i badającym. Tu przede wszystkim badający powinien dążyć do uzyskania zwrotnej informacji od badanego oraz postawić na jego zaktywizowanie.
4. Następnym etapem jest wyjaśnianie i planowanie. W tym miejscu zadania badającego sprowadzają się do tego, aby przekazać pacjentowi niezbędne informacje dotyczące jego sytuacji zdrowotnej oraz pomóc mu ją zrozumieć i odnaleźć się w niej oraz zapamiętać wszystkie niezbędne dane. Na koniec badający planuje z pacjentem przebieg dalszego postępowania, szanując jego decyzje, poznając oczekiwania i postawy.
5. Ostatnim etapem w wymienianym schemacie badania jest zakończenie spotkania z pacjentem.

Badanie podmiotowe powinno być prowadzone systematycznie, tak aby nie pominąć ważnych elementów w sytuacji zdrowotnej chorego. W jakiej kolejności można zadawać pytania? W tabeli 2.1 przedstawiono kolejność zadawania pytań według **OLDCART**.

Tabela 2.1. Schemat zbierania danych OLDCART

O (onset) – kiedy rozpoczęły się dolegliwości?
L (location) – gdzie jest miejsce odczuwania dolegliwości?
D (duration) – jak długo pacjent odczuwa daną dolegliwość/dolegliwości?
C (characteristics) – jak może opisać/scharakteryzować swoje dolegliwości?
A (aggraviting) – jakie są czynniki, które pogarszają dany objaw/objawy?
R (relieving factors) – jakie są czynniki, które łagodzą dolegliwości?
T (treatment) – jakie leczenie dotychczas zastosowano?

W medycynie ratunkowej, biorąc pod uwagę specyfikę stanu pacjenta znajdującego się w stanie zagrożenia życia, często stosowany jest **system AMPLE** (tab. 2.2), który zakłada uzyskanie informacji od samego pacjenta, jeśli jest on w stanie odpowiedzieć na pytania i nie powoduje to skrajnego pogorszenia jego kondycji fizycznej, lub od najbliższych pacjenta, świadków zdarzenia, znajomych.

Tabela 2.2. Schemat zbierania danych AMPLE

A	**(allergies)** – na jakie leki lub inne substancje chory jest uczulony?
M	**(medication)** – jakie leki pacjent przyjmuje/przyjmował?
P	**(past medical history)** – na jakie choroby pacjent do tej pory się leczył? (pytania koncentrują się na przeszłości chorobowej pacjenta)
L	**(last meal)** – kiedy pacjent spożywał ostatni posiłek? (ma to istotne znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia chorego i planowany jest zabieg operacyjny w trybie pilnym z zastosowaniem znieczulenia ogólnego; to ważne pytanie o ostatni posiłek dotyczy grupy między innymi chorych na cukrzycę, aby rozpoznać np. stan niedocukrzenia)
E	**(environment)** – jakie były okoliczności zdarzenia, jak do niego doszło? (z odpowiedzi na pytania o to, co miało miejsce, można poznać mechanizm urazu lub bezpośrednią przyczynę stanu chorobowego pacjenta)

W badaniu podmiotowym występują pewne istotne stałe elementy – od danych ogólnych dotyczących pacjenta do wywiadu z zakresu dolegliwości ze strony poszczególnych układów i narządów.

DANE OGÓLNE

Przed badaniem podmiotowym należy zebrać podstawowe informacje personalne pacjenta oraz dane dotyczące poradni, w której się do tej pory leczył lub która kieruje go na leczenie, i dane ubezpieczyciela. Informacje te zawierają:

- imię i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia (numer PESEL),
- miejsce zamieszkania,
- wykształcenie,
- zawód wykonywany,
- stan cywilny,
- rodzaj ubezpieczenia (numer ubezpieczenia),
- nazwę jednostki kierującej pacjenta do poradni/szpitala,
- imię i nazwisko lekarza rodzinnego/pielęgniarki, położnej środowiskowej, rodzinnej,
- imię i nazwisko, adres osoby najbliższej (stopień spokrewnienia) i jej numer telefonu do celów informacyjnych.

2.3. WYWIAD DOTYCZĄCY AKTUALNEGO STANU ZDROWIA

W tej części wywiadu powinny się znaleźć dane dotyczące sytuacji zdrowotnej pacjenta. Zadaje się pytania ukierunkowane na ewentualne czynniki ryzyka chorób, postawy chorego i nawyki żywieniowe oraz zażywane dotychczas leki.

- **Przyzwyczajenia żywieniowe** należy ocenić w badaniu podmiotowym. Trzeba zapytać o rodzaj diety w codziennym odżywianiu, sposób przygotowywania posiłków, jakość i liczbę posiłków, ich regularność, ilość przyjmowanych płynów między posiłkami, stopień urozmaicenia diety w warzywa, owoce. Z odpowiedzi pacjenta dotyczących sposobów odżywiania można wyciągnąć wioski o czynnikach ryzyka choroby wieńcowej, cukrzycy, niedoborów witamin i składników mineralnych.
- Bardzo często pacjent **przyjmuje leki**, które w jego mniemaniu nie mają większego znaczenia w stosunku do zgłaszanych dolegliwości, np. tabletki antykoncepcyjne, leki przyjmowane w ramach hormonalnej terapii zastępczej, suplementy diety (witaminy, składniki mineralne, tabletki odchudzające, preparaty lecytyny, preparaty poprawiające wydolność psychiczną i fizyczną, anaboliki). Poza tym istotnym elementem zgłaszanych objawów są skutki uboczne leków, które pacjent zażywa, np. leki z grupy nitratów powodują

osłabienie, ból głowy lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Podczas przyjmowania środków blokujących receptory beta-adrenergiczne dochodzi do zwolnienia czynności serca, które może być słabo tolerowane przez chorego (osłabienie, obniżone ciśnienie tętnicze krwi, bradykardia). Leki mogą powodować również odczyny alergiczne o różnym stopniu nasilenia. Ważne jest, aby starać się ustalić zależność między tymi objawami, które pacjent zgłasza, a ewentualnym rozpoczęciem przyjmowania leków czy ich zakończeniem. Ustalić również trzeba okoliczności, w jakich pacjent dany preparat zażył, co mogło spowodować przejściowe złe samopoczucie, np. zażycie nitrogliceryny w przypadku bólu w klatce piersiowej, kiedy ciśnienie tętnicze skurczowe było niższe niż 90 mmHg, mogło jeszcze bardziej je obniżyć. U pacjentów, którzy leczą się na nadciśnienie i przyjmują leki moczopędne, mogą się pojawić dolegliwości w postaci zaburzeń czynności elektrycznej serca (zaburzenia rytmu), kiedy dochodzi do wypłukiwania przez te środki potasu, a nie jest stosowana suplementacja tego pierwiastka.

- Inną ważną wskazówką w odniesieniu do przyjmowania przez pacjenta leków jest jego świadomość **regularnego ich przyjmowania**. Dotyczy to szczególnie preparatów stale przyjmowanych. Należy się upewnić, czy chory przyjmuje je systematycznie, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego, czy stosuje odpowiednie dawki, czy zażywa wszystkie leki czy tylko wybiórczo (co może być związane z trudnościami finansowymi związanymi z wykupieniem wszystkich koniecznych leków). Nieprawidłowe przyjmowanie leków może być spowodowane nie tylko brakiem świadomości chorego i niepełną wiedzą dotyczącą leczenia, lecz także zanikami pamięci (wiek, choroby ośrodkowego układu nerwowego).
- Kolejnym elementem wywiadu są **uczulenia na leki i inne substancje**. Jeśli pacjent wskazuje, że jest uczulony na dany lek, trzeba ustalić związek czasowy między reakcją alergiczną a przyjęciem zaleconej dawki leku.
- W odniesieniu do pacjentów nieprzytomnych wywiad dotyczący leków należy starać się zebrać od osób, które znają chorego. Może to ułatwić rozpoznanie przyczyny nieprzytomności (np. osoby chore na cukrzycę mogą być w stanie hipoglikemii bądź hiperglikemii i to będzie bezpośrednią przyczyną ich stanu; bardzo często pacjenci mają przy sobie informacje, np. bransoletki, o swojej chorobie, cukrzycy, padaczce czy innych).

Przebyte choroby, pobyty w szpitalu i zabiegi operacyjne stanowią istotną część badania podmiotowego, gdyż pozwalają powiązać stwierdzane i zgłaszane przez pacjenta objawy z ewentualną leczoną wcześniej chorobą.

Należy zapytać pacjenta o dotychczasowe pobyty w szpitalu i przyczyny leczenia (data i miejsce leczenia oraz sposoby podjętego leczenia). Warto również zadać pytanie, czy posiada karty informacyjne z pobytów w szpitalu (pacjent ma obowiązek okazywania ich przy każdorazowej konsultacji lub wizycie), wyniki badań dodatkowych, np. elektrokardiogram, aby porównać ewolucję zmian zapisu. Należy zapytać o przebyte choroby, nie wyłączając pytań o choroby psychiczne. Poza tym pytania o przebyte choroby trzeba powiązać z pytaniami o obecne dolegliwości. Na przykład jeśli pacjent zgłasza ból w klatce piersiowej, trzeba zapytać go o to, czy kiedykolwiek miewał już taki ból i czy choruje na chorobę wieńcową, czy przebył zawał serca, czy leczy się na nadciśnienie tętnicze, czy w rodzinie stwierdzono hipercholesterolemię rodzinną (jako czynnik ryzyka chorób naczyń krwionośnych i mózgowych). Ten etap badania wymaga od badającego wnikliwej wiedzy, gdyż dokonuje się wtedy wstępnego różnicowania możliwych przyczyn dolegliwości pacjenta.

2.4. WYWIAD DOTYCZĄCY DOLEGLIWOŚCI ZE STRONY NARZĄDÓW I UKŁADÓW

Ta część badania jest niezwykle trudna, gdyż na tym etapie badający różnicuje objawy i stara się wyciągnąć trafne wnioski diagnostyczne, aby ostatecznie z powodzeniem móc ustalić rozpoznanie stanu pacjenta. Jak wspomniano wcześniej, prawidłowo przeprowadzone badanie podmiotowe może w znacznej mierze w tym pomóc. Dopełnienie stanowić będą badanie fizykalne i wyniki badań dodatkowych.

Dolegliwości ogólne są to, tak jak nazwa wskazuje, bliżej nieokreślone objawy, które odczuwa sam pacjent. Nie mają one często swojego umiejscowienia w konkretnym narządzie czy układzie. Są to najczęściej objawy niespecyficzne, nieswoiste dla danej choroby, mogą oznaczać wiele negatywnych procesów w ustroju, np. odczuwanie osłabienia, zmęczenie, utrata łaknienia, chudnięcie, podwyższona temperatura ciała.

Niżej przedstawiono główne dolegliwości układów krążenia, oddechowego, pokarmowego oraz narządów zmysłów zgłaszane przez pacjenta (tab. 2.3–2.7).

Tabela 2.3. Najczęstsze objawy dysfunkcji układu krążenia

- Ból w klatce piersiowej
- Duszność
- Kołatanie serca, uczucie nierównego bicia serca
- Spadki/podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi
- Omdlenia, zawroty głowy
- Nietolerancja wysiłku fizycznego

Tabela 2.4. Najczęstsze objawy dysfunkcji układu oddechowego

- Duszność
- Kaszel
- Odkrztuszanie plwociny
- Krwioplucie
- Ból w klatce piersiowej

Tabela 2.5. Najczęstsze objawy dysfunkcji ze strony narządów zmysłów

- Upośledzenie słuchu, ból ucha, szum w uszach, zawroty głowy
- Niedowidzenie, ból oka
- Podwójne widzenie
- Łzawienie, swędzenie
- Upośledzenie węchu, wyostrzenie węchu
- Upośledzenie czucia smaku

Tabela 2.6. Najczęstsze objawy dysfunkcji układu pokarmowego

- Utrudnienie połykania
- Ból brzucha, wzdęcie brzucha
- Brak łaknienia, zgaga
- Utrata masy ciała
- Wymioty, nudności
- Biegunka, zaparcia

Tabela 2.7. Najczęstsze objawy dysfunkcji ze strony układu nerwowego

- Zawroty głowy, bóle głowy
- Osłabienie siły mięśniowej
- Trudności w poruszaniu się
- Zaburzenia czucia
- Napady drgawek
- Omdlenia, utraty przytomności

Pamiętaj: Pytania w odniesieniu do każdego układu zadawaj systematycznie, koncentrując się na punktach schematu OLDCART lub innego wybranego schematu, co nie pozwoli pominąć dynamiki danego objawu!

2.5. WYWIAD RODZINNY I ŚRODOWISKOWY

Koniecznie zebrana powinna być część wywiadu poświęcona sytuacji rodzinnej i socjalnej pacjenta, gdyż stanowi źródło informacji dotyczących tego, jak pacjent i jego rodzina radzą sobie z problemami związanymi ze swoim stanem zdrowia oraz jaki wpływ obecny stan wywiera na funkcjonowanie pacjenta w środowisku rodzinnym lub środowisku pracy (zwłaszcza gdy mamy do czynienia z chorym w wieku podeszłym, z licznymi ograniczeniami fizycznymi, neurologicznymi, psychicznymi).

Wywiad rodzinny ma na celu przede wszystkim poszukiwanie obciążeń genetycznych, przyczyn zgonów członków najbliższej rodziny, przewidywanie ewentualnych chorób, które mogą być dziedziczone. Ważne jest również to, aby pamiętać, że analiza przyczyn zgonów lub chorób występujących w rodzinie może uświadomić pacjentowi jego zadania w zakresie profilaktyki powikłań niektórych schorzeń, np. dotyczących układu krążenia, układu nerwowego lub chorób metabolicznych. Pozwoli mu zrozumieć konieczność dostrzegania objawów, ustosunkować się do nich i właściwie reagować.

Elementy wywiadu socjalnego powinny skupiać się na sposobach radzenia sobie chorego z codziennymi zadaniami (dotyczy to zwłaszcza osób samotnych, starszych, z deficytami fizycznymi, neurologicznymi), tzn. należy zapytać pacjenta (lub jego opiekuna) o radzenie sobie z przemieszczaniem się po mieszkaniu, w obrębie łóżka, spożywanie posiłków i stopień samodzielności podczas ich przygotowywania, zakres czynności wykonywanych samodzielnie podczas toalety własnej, sposób zaspokajania potrzeby wydalania. Oczywiście ważne są również pytania nakierowane na szeroko pojęty styl życia pacjenta: aktywność fizyczną (ćwiczenia fizyczne, ich częstotliwość, dziedziny sportu, które stanowią hobby pacjenta), sposób spędzania urlopów (głównie chodzi tu o podróże mogące powodować styczność z groźnymi dla życia drobnoustrojami), środki odurzające (są to trudne pytania i mogą one nie być dobrze odebrane, jednakże, biorąc pod uwagę wiek pacjenta i obserwacje poczynione w czasie badania podmiotowego, mogą okazać się zasadne). Istotne jest pytanie o spożywanie alkoholu

(jaka jest jego ilość i – jeśli pacjent potwierdza jego spożywanie – jak często to ma miejsce), palenie papierosów (jak długo i ile papierosów dziennie pacjent pali), picie kawy. Ponieważ czynnikiem, który osłabia organizm, w znacznym stopniu przyczyniając się tym samym do licznych chorób, jest stres, konieczne jest zadanie pytań o jego wpływ na badanego (stopień narażenia na stres w szkole, pracy, w miejscu zamieszkania i sposoby radzenia sobie w sytuacjach napięć).

PIŚMIENNICTWO

1. Epstein O., Perkin D., de Bono D., Cookson J.: *Badanie kliniczne* (wyd. polskie pod red. M. Sikorskiego, A. Sikorskiej). Wydawnictwo Czelej, Lublin 2001.
2. Maxwell A.A., Marsh J.: *Wywiad i badanie przedmiotowe* (wyd. polskie pod red. F. Kokota). Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004.
3. Tatoń J., Czech A.: *Diagnostyka internistyczna*. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

3. PODSTAWY BADANIA PRZEDMIOTOWEGO

Danuta Dyk

Badanie przedmiotowe daje możliwość oceny stanu osoby badanej poprzez identyfikację symptomów obiektywnych (przedmiotowych). W celu precyzyjnego posługiwania się technikami badania przedmiotowego (fizykalnego) nieodzowne staje się przypomnienie podstaw anatomii topograficznej ułatwiającej umiejscowienie rozpoznanych objawów.

3.1. PODSTAWY ANATOMII TOPOGRAFICZNEJ

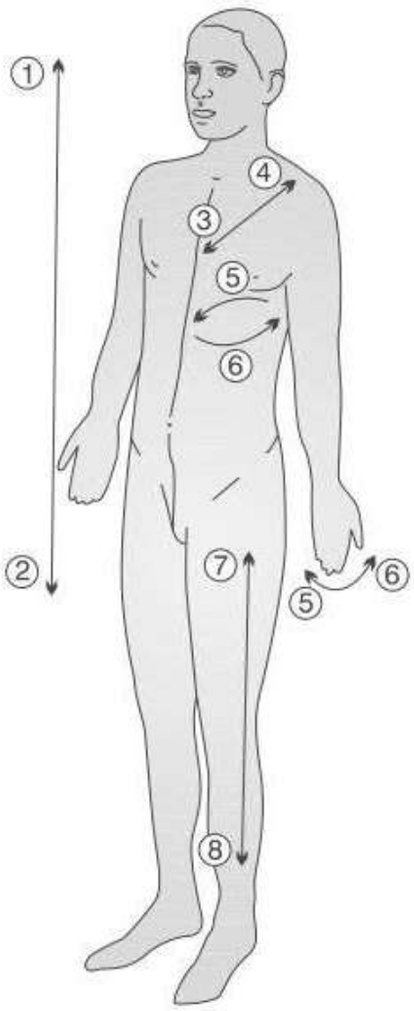
Stosowanie tej samej terminologii przez lekarzy, pielęgniarki, fizykoterapeutów ułatwia komunikowanie się w zespołowym świadczeniu usług medycznych.

Ustalona pozycja anatomiczna – ciało jest w pozycji stojącej, wyprostowane, stopy złączone na podłożu, ramiona wyprostowane, powierzchnie dłoniowe rąk skierowane do przodu, a kciuki na zewnątrz.

KIERUNKI CIAŁA

- **Górny/dogłowowy** (*superior/cranialis*) oznacza w kierunku głowy lub najwyższej części ciała, np. staw ramienny jest położony do góry od stawu łokciowego, a staw łokciowy do góry od stawu nadgarstkowego.
- **Dolny/doogonowy** (*anterior/caudalis*) oznacza w kierunku ogona lub najniżej położonej części ciała, np. staw łokciowy jest położony do dołu od stawu ramiennego, a staw skokowy jest położony do dołu od stawu kolanowego.
- **Przedni/brzuszny** (*anterior/ventralis*) oznacza w kierunku do przodu lub do powierzchni brzusznej ciała, np. mostek znajduje się do przodu od serca, a serce leży do przodu od kręgosłupa.
- **Tylny/grzbietowy** (*posterior/dorsalis*) oznacza w kierunku grzbietowej powierzchni ciała, np. serce leży do tyłu od mostka, a kręgosłup znajduje się do tyłu od serca.
- **Przyśrodkow**y (*medialis*) oznacza położenie w kierunku linii pośrodkowej ciała, np. kręgosłup znajduje się przyśrodkowo.
- **Boczny** (*lateralis*) oznacza w kierunku do boku ciała od linii pośrodkowej, np. ramiona położone są bocznie do tułowia.

- **Bliższy** (*proximalis*) oznacza w kierunku miejsca przyczepu lub początku części ciała lub bliskie sąsiedztwo do początku lub przyczepu, np. ramię jest bliżej położone niż nadgarstek.
- **Dalszy** (*distalis*) oznacza w kierunku miejsca przyczepu lub początku części ciała lub względną odległość od miejsca początku lub przyczepu, np. nadgarstek jest dalej położony niż ramię.
- **Powierzchowny** (*superficialis*) oznacza bliskie sąsiedztwo powierzchni, np. naskórek jest położony powierzchownie w stosunku do skóry właściwej.
- **Głęboki** (*profundus*) oznacza położenie poniżej powierzchni na różnych poziomach, np. skóra właściwa leży głębiej niż naskórek.

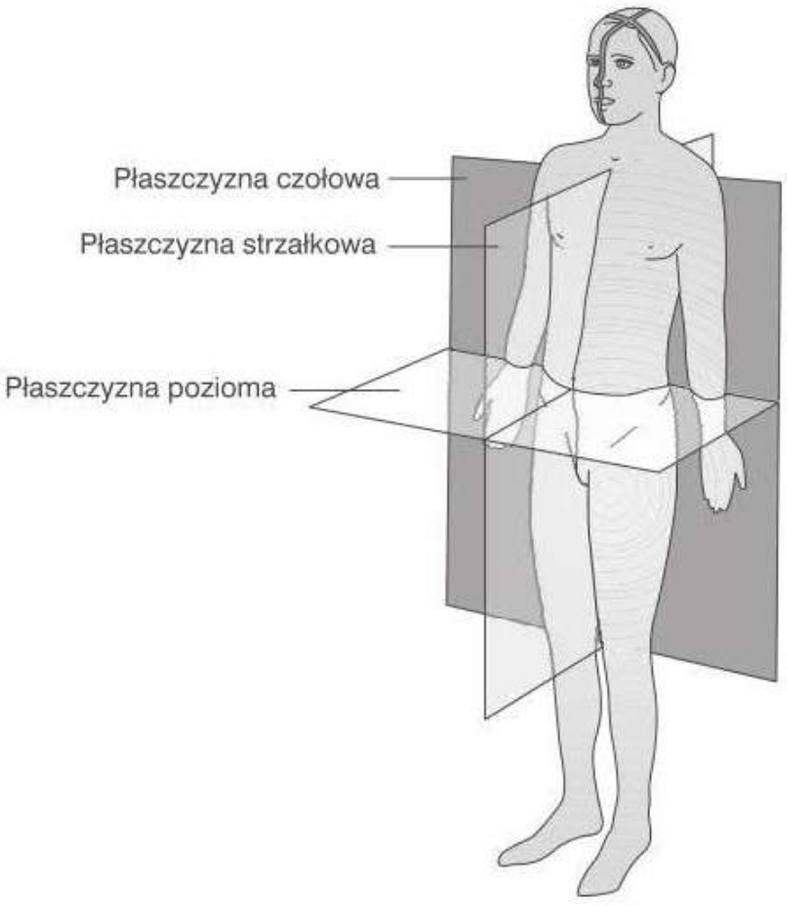


Rycina 3.1. *Pozycja anatomiczna i kierunki ciała:*
1 – górny/dogłowowy, 2 – dolny/doogonowy, 3 – przedni, 4 – tylny,
5 – przyśrodkowy, 6 – boczny, 7 – bliższy, 8 – dalszy.

PŁASZCZYZNY CIAŁA

W przestrzennej budowie ciała ludzkiego można wyodrębnić trzy płaszczyzny (ryc. 3.2):

- **Płaszczyzna strzałkowa (pośrodkowa)** – dzieli ciało na części prawą i lewą.
- **Płaszczyzna czołowa (wieńcowa)** – prostopadła do strzałkowej, dzieli ciało na część przednią i tylną.
- **Płaszczyzna pozioma (poprzeczna)** – przebiega prostopadle do obu płaszczyzn (strzałkowej i czołowej), dzieli ciało na część górną i dolną.



Rycina 3.2. *Płaszczyzny ciała.*

LINIE CIAŁA

Na powierzchni ciała, zwłaszcza na tułowiu, wyróżnia się linie podłużne i poprzeczne ciała (ryc. 3.3).

Linie podłużne ciała biegnące pośrodkowo, nieparzyste:

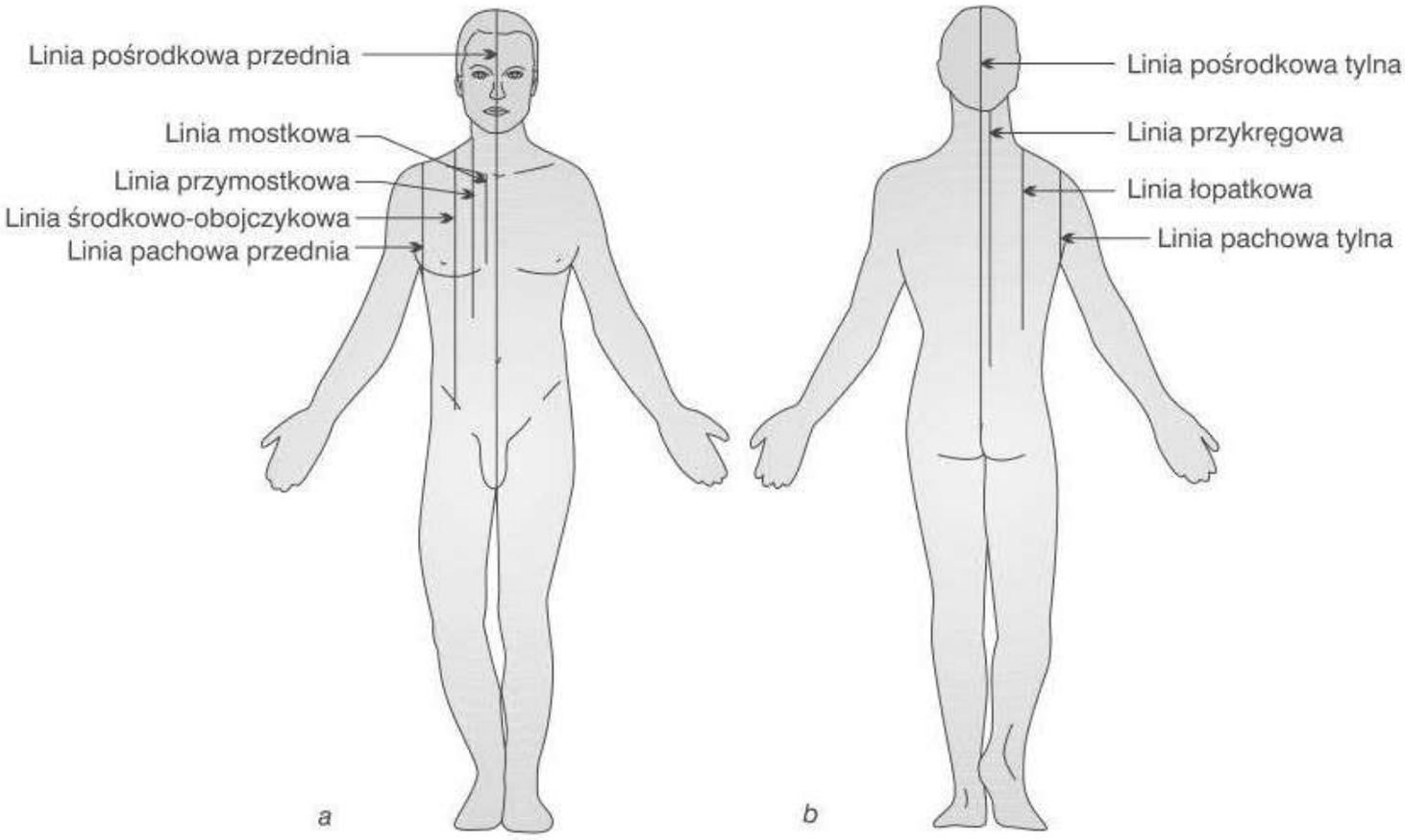
- **Linia pośrodkowa przednia** – biegnie przez głowę, szyję i tułów, jest osią symetrii przedniej prawej i lewej połowy ciała.

- **Linia pośrodkowa tylna** – biegnie przez głowę, kark i grzbiet, jest osią symetrii tylnej prawej i lewej połowy ciała.

Linie podłużne ciała, parzyste:

- **Linia mostkowa (prawa i lewa)** – biegnie wzdłuż brzegów mostka.
- **Linia przymostkowa (prawa i lewa)** – biegnie w połowie odległości między linią mostkową a środkowo-obojczykową.
- **Linia środkowo-obojczykowa (prawa i lewa)** – biegnie przez środek obojczyka.
- **Linia pachowa przednia (prawa i lewa)** – biegnie wzdłuż brzegu mięśnia piersiowego większego.
- **Linia pachowa środkowa (prawa i lewa)** – biegnie od szczytu każdej pachy.
- **Linia pachowa tylna (prawa i lewa)** – biegnie wzdłuż mięśnia najszerszego grzbietu.
- **Linia przykręgowa (prawa i lewa)** – biegnie tuż przy kręgosłupie po obu stronach.

Linia łopatkowa (prawa i lewa) – biegnie przez dolny kąt łopatki.



Rycina 3.3 *a, b. Linie ciała.*

Linie poprzeczne na tułowiu:

- Linia poprzeczna przebiegająca przez brodawki sutkowe.
- Linia górna poprzeczna przebiegająca przez najniżej położone punkty X żeber.
- Linia przebiegająca przez pępek.
- Linia dolna poprzeczna przebiegająca przez najwyżej położone punkty grzebieni biodrowych.

JAMY CIAŁA

Narządy wewnętrzne położone są w jamach ciała (tab. 3.1 i ryc. 3.4) wysłanych gładkimi błonami surowiczymi.

Patrząc od przodu, wyodrębnia się **brzuszną jamę ciała**, która dzieli się na **jamę klatki piersiowej** i **jamę brzuszną**.

Jama klatki piersiowej ciągnie się od przodu od mostka do tyłu do kręgów piersiowych, a od góry od otworu górnego klatki piersiowej do dołu do przepony. Zawiera płuca i opłucną, serce i początkowe odcinki dużych naczyń oraz śródpiersie, a w nim grasicę, tchawicę, przełyk, naczynia chłonne, węzły chłonne i nerwy.

Jama brzuszna rozciąga się od przepony do dna miednicy i jest podzielona na **jamę brzuszną właściwą** i **jamę miednicy**.

Jama brzuszna właściwa zawiera: wątrobę, drogi żółciowe, śledzionę, trzustkę, żołądek, większość jelita cienkiego, części jelita grubego, nerki, nadnercza i moczowody.

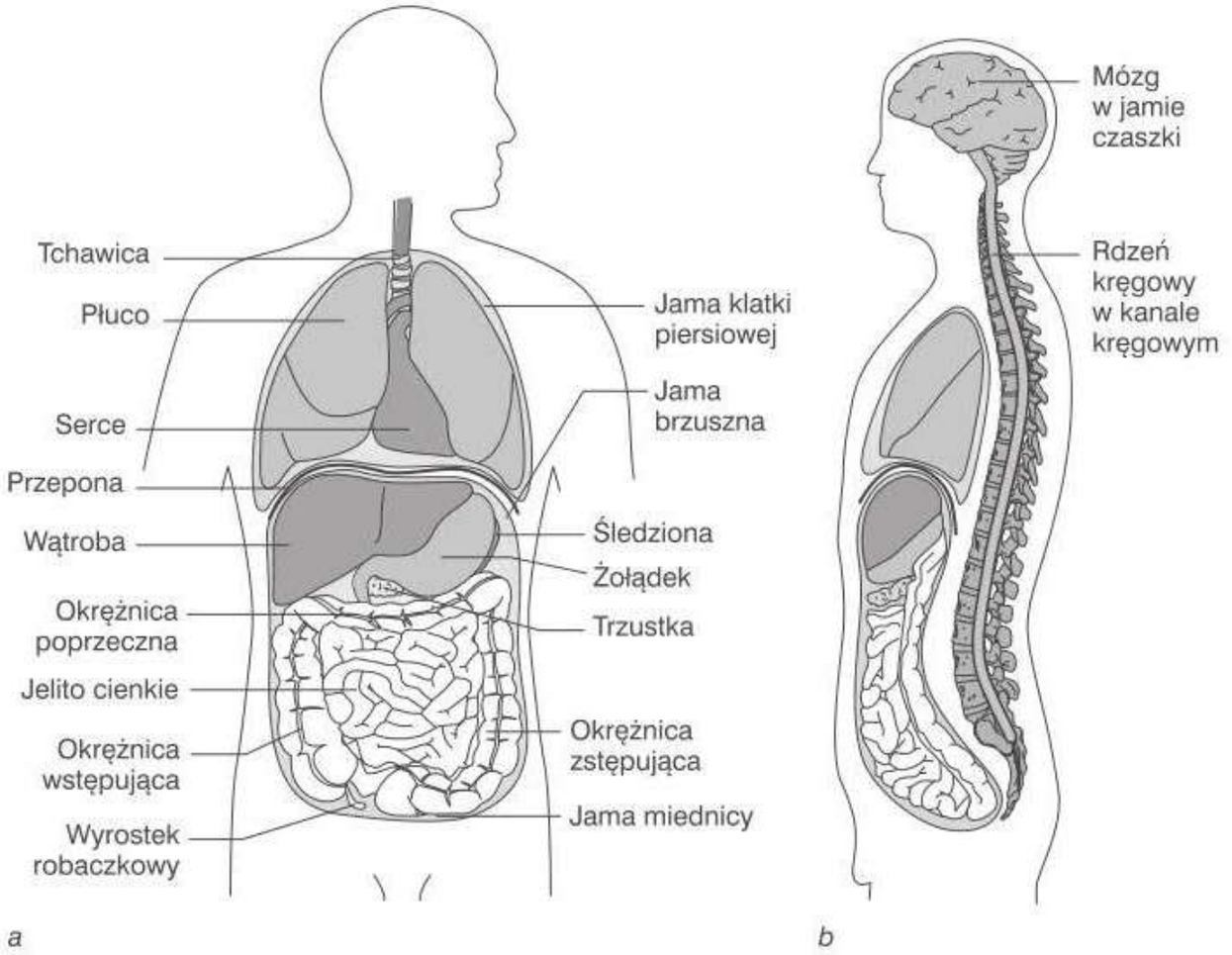
Jama miednicy zawiera: okrężnicę esowatą, odbytnicę, pęcherz moczowy oraz części układu rozrodczego męskiego i żeńskiego.

Do tylnej powierzchni ciała jest zwrócona **jama grzbietowa**, która zawiera **jamę czaszki** i **kanał kręgowy**.

Jama czaszki zawiera mózg, a **kanał kręgowy** – rdzeń kręgowy oraz początkowe odcinki nerwów rdzeniowych wychodzących z rdzenia kręgowego.

Tabela 3.1. Jamy ciała

JAMA BRZUSZNA CIAŁA	JAMA GRZBIETOWA CIAŁA
• Jama klatki piersiowej	• Jama czaszki
• Jama brzuszna (jama brzuszna właściwa i jama miednicy)	• Kanał kręgowy



Rycina 3.4. *Jamy ciała: a – jama brzuszna; b – jama grzbietowa.*

3.2. METODY I OGÓLNE ZASADY BADANIA PRZEDMIOTOWEGO

W badaniu przedmiotowym stosowane są cztery podstawowe metody: oglądanie, obmacywanie (palpacja), opukiwanie i osłuchiwanie, z użyciem zmysłów wzroku, dotyku i słuchu.

Oglądanie (*inspectio*). Jest to najistotniejsza z metod. Rozpoczyna się od pierwszego momentu kontaktu z badanym i wykorzystywana jest zarówno w ocenie stanu ogólnego, jak i w badaniu poszczególnych części ciała.

Oglądanie stanu ogólnego pacjenta rozpoczyna się od oceny symetrii i uchwytnych objawów różnicujących, np. położenie powiek prawego i lewego oka, barków prawego i lewego, stawów kolanowych prawego i lewego itp.

W szczegółowym badaniu metodą oglądania często wykorzystuje się powiększenie, np. oftalmoskop w badaniu dna oka, otoskop w badaniu przewodu

słuchowego, przewodu nosowego, oraz punktowe źródła światła, np. do oglądania ruchomości źrenic, oceny gardła.

Obmacywanie, palpacja (*palpatio*). W tej metodzie badający wykorzystuje zmysł dotyku. Badanie wykonuje się dłońmi i w zależności od badanej okolicy może być przeprowadzane całą dłonią, np. obmacywanie powierzchowne jamy brzusznej, albo jednym lub kilkoma palcami, np. obmacywanie tarczycy, węzłów chłonnych, uderzenia koniuszkowego. Najbardziej wrażliwe na dotyk w części dłoniowej ręki są opuszki palców, ale grzbiet ręki jest bardziej czuły na temperaturę, ponieważ skóra w tym miejscu jest cieńsza.

Badanie metodą obmacywania zaczyna się zwykle od delikatnych powierzchownych ruchów ręki, aby badany przyzwyczaił się do dotyku i nie reagował obroną mięśniową. Następnie, w zależności od celu badania, zwiększa się ucisk, przechodząc do głębokiego obmacywania, np. granic narządów jamy brzusznej.

Za pomocą tej metody ocenia się m.in. ucieplenie, tkliwość, wilgotność, konsystencję, napięcie (np. skóry, guza czy gruczołu piersiowego).

Opukiwanie (*percussio*). Metoda pozwala uzyskać informacje np. o granicach narządów wewnętrznych, obecności w jamach ciała płynu albo gazu i o wielkości innych zmian. Miejsca opukiwane różnicuje się na podstawie odgłosu opukowego (tab. 3.2), którego charakter zależy od ilości powietrza znajdującego się w opukiwanym miejscu.

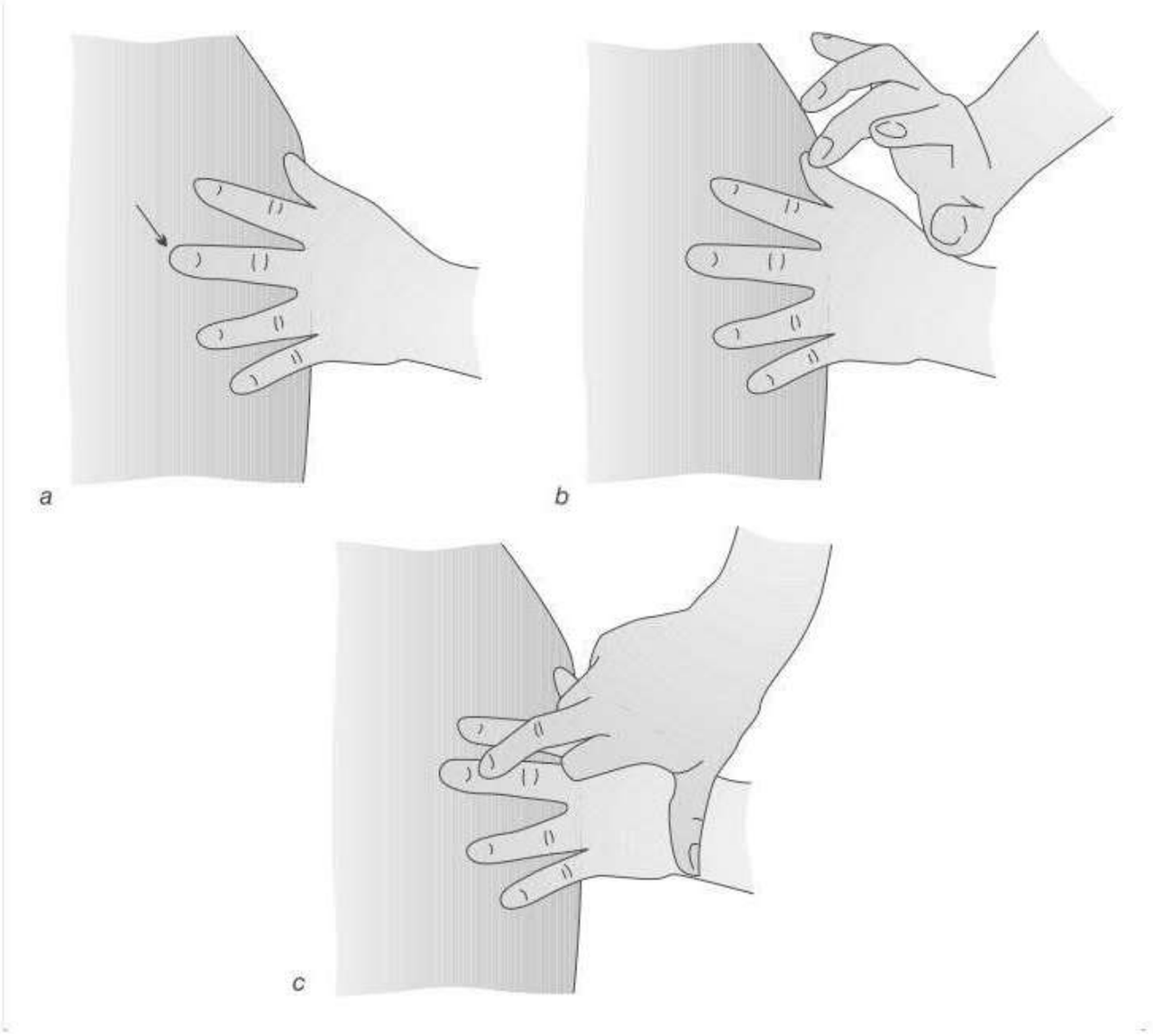
Tabela 3.2. Rodzaje odgłosów opukowych

Odgłos opukowy jawny	niezbyt głośny, niski, dość długo słyszalny ton, charakterystyczny dla prawidłowo powietrznej tkanki płucnej
Odgłos opukowy nadmiernie jawny	głośniejszy, długo słyszalny ton o dudniącym charakterze; prawidłowy u dzieci, u dorosłych świadczy o nadmiernej powietrzności (rozedma i odma płuc)
Odgłos opukowy bębenkowy	niezbyt głośny i długo słyszalny ton, wyższy niż rezonans; występuje nad jamą wypełnioną powietrzem (np. żołądek, jelito); im wyższe ciśnienie w jamie, tym wyższy ton wypuku
Odgłos opukowy stłumiony (stępiony)	krótki, wysoki i cichy ton; jego obecność świadczy o gorszej powietrzności narządu; występuje, gdy są nacieki w płucach, płyn lub zrosty; także nad sercem, wątrobą

Technika opukiwania – palec opukiwany, tj. środkowy lewej ręki, palec opukujący, tj. środkowy prawej ręki (ryc. 3.5):

- Palec opukiwany przylega powierzchnią pierwszego i drugiego paliczka do miejsca opukiwanego.

- Palec opukujący uderza pod kątem prostym w środkowy paliczek palca opukiwanego.
- Ruch ręki opukującej powinien być ograniczony do stawu nadgarstkowego.
- Uderzenie powinno być krótkie, a palec opukujący szybko uniesiony po uderzeniu.
- Każde miejsce opukuje się dwukrotnie z identyczną siłą.
- Siła opukiwania zależna jest od miejsca opukiwanego.

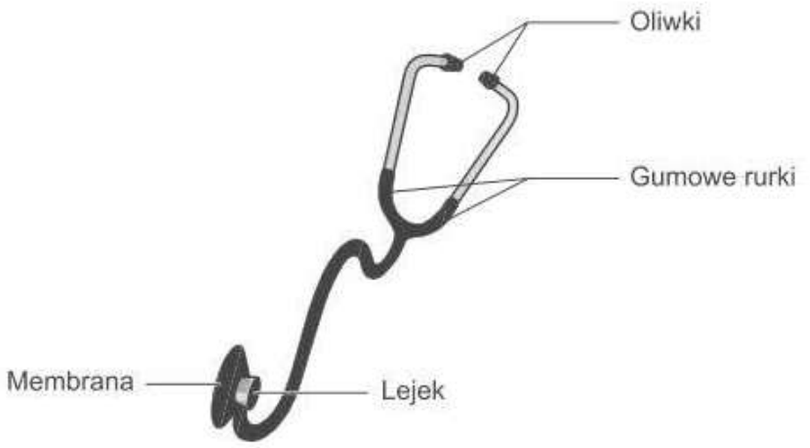


Rycina 3.5 *a–c. Technika opukiwania.*

Osłuchiwanie (*ascultatio*). Metoda polega na odbieraniu wrażeń słuchowych z badanej powierzchni ciała. Dźwięki osłuchuje się fonendoskopem, zwanym też stetoskopem. Odbierane są one za pomocą lejkowatej końcówki lub bębenka z membraną i przenoszone do uszu za pośrednictwem gumowych rurek.

Dźwięki o wyższej częstotliwości są odbierane lepiej przez membranę (np. szmery płucne, tony serca, dźwięki jelitowe), a dźwięki o niższej częstotliwości – przez lejek (np. szmery serca, szmery naczyniowe).

Podczas osłuchiwania membraną odbierane są dźwięki z większej powierzchni, ale musi ona dokładnie przylegać do osłuchiwanego miejsca. Lejek nie powinien zbyt mocno przylegać, ale pozwala osłuchać przestrzenie węższe, np. międzyżebrza u osób wychudzonych.



Rycina 3.6. *Schemat stetoskopu (fonendoskopu).*

Ogólne zasady badania przedmiotowego:

- Zapewnienie prywatności.
- Poinformowanie o zakresie i celu badań, udzielanie wyraźnych instrukcji.
- Uzyskanie zgody osoby badanej.
- Dobre ogrzanie i oświetlenie (w miarę możliwości oświetlenie dzienne) pomieszczenia, w którym odbywa się badanie.
- Umycie rąk przed badaniem w ciepłej wodzie, najlepiej w obecności badanego (czyste, **ciepłe ręce badającego**).
- Podczas całkowitego badania najpierw proszenie chorego o odsłonięcie górnej części ciała, a później dolnej.
- Wcześniejsze przygotowanie niezbędnego sprzętu (stetoskop, aparat do mierzenia ciśnienia krwi, szpatułki, latarka, młotek neurologiczny).
- Zapewnienie dostępu z prawej strony pacjenta, ułożenie adekwatne do stanu pacjenta i badanego układu.

- Przeprowadzanie badania według przyjętego schematu: w pierwszej kolejności ogólne (ocena stanu ogólnego, wygląd i zachowanie się pacjenta), następnie szczegółowe (narządowe).

3.3. BADANIE PRZEDMIOTOWE OGÓLNE I DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW

Podczas pierwszego spotkania z osobą badaną trzeba ocenić, czy możliwe jest nawiązanie z nią kontaktu słownego. Czy pacjent w czasie powitania lub zadawania pytania jest zorientowany, gdzie się znajduje; potrafi się przedstawić, czy może nie odpowiada na kierowane słowa oraz inne bodźce zewnętrzne i nie przejawia aktywności psychicznej?

3.3.1. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY – PIERWSZE WRAŻENIE

Wyraz twarzy podczas odpoczynku i kontaktu z innymi – smutny wyraz twarzy lub odwrotnie, wesołkowatość i niewłaściwe do sytuacji zachowania wskazujące na zaburzenia w sferze psychicznej.

Mowa i język – ilość i tempo wypowiadanych słów oraz swoboda ich wypowiadania, właściwe nazywanie przedmiotów i osób.

Nastrój – poczucie szczęścia, podwyższenie nastroju, niepokój, gniew, obojętność (ryzyko samobójstwa).

Zaburzenia psychiczne – wypowiadanie sądów, które nie znajdują uzasadnienia w rzeczywistości, zachowania wskazujące na objawy choroby psychicznej, takie jak ogromny lęk przed kimś lub przed czymś demonstrowany w sytuacji, gdy takiego zagrożenia nie ma.

Sposób chodzenia – prawidłowo podczas chodzenia obserwuje się, że postawa człowieka jest wyprostowana oraz występuje współruch kończyn górnych. Nieprawidłowości chodu są objawem poważnych chorób układu nerwowego, np. pociąganie za sobą ruchem koszącym kończyny – porażenie, lub mogą wskazywać na zaburzenia w układzie kostno-stawowym, np. krótsza kończyna dolna, złamanie kończyny.

Przyjmowana pozycja siedząca, ułożenie w łóżku – pozycja, jaką pacjent przyjmuje, może wskazywać na jego ograniczenia w zakresie poruszania się, ale również może być dla niego pozycją wymuszoną, np. w czasie duszności pacjent przyjmuje pozycję półsiedzącą lub siedzącą, aby poprawić jakość oddychania, podczas bólu brzucha najczęściej leży na boku z podkurczonymi kończynami

dolnymi. Trzeba również zwrócić uwagę, czy pacjent może pozostawać w jednej pozycji, czy jest pobudzony, przyjmuje dziwaczne pozycje, ma ruchy mimowolne, czy pozostaje w bezruchu.

Sposób ubierania się – wnosi wiele cennych wskazówek co do aktualnego stanu zdrowia. Osoby starsze zakładają więcej ubrań nawet, gdy jest ciepło na zewnątrz, gdyż odczuwają zimno (cieńsza tkanka podskórna). Pacjenci cierpiący na schorzenia tarczycy nie tolerują ciepła lub zimna i ich ubranie nie będzie odpowiednie do warunków zewnętrznych. Osoby, które zakrywają pewne części ciała, mogą doświadczać przemocy fizycznej lub nadużywać środków odurzających podawanych drogą dożylną.

3.3.2. BUDOWA I PROPORCJE CIAŁA, WZROST I STAN ODŻYWIENIA

Budowę ciała określa się według następujących typów konstytucyjnych: atletyczny, asteniczny, pykniczny. Każdy z nich prezentuje pewne cechy. W budowie ciała **typu atletycznego** obserwuje się dobrze rozwinięte mięśnie, proporcjonalną budowę ciała. W **typie astenicznym** występuje szczupła sylwetka oraz znamiennie wąska i długa klatka piersiowa, obojczyki i łopatki są odstające. Natomiast **typ pykniczny** charakteryzuje się skłonnością do otyłości, szyja i kończyny są krótkie.

Proporcje ciała zmieniają się w zależności od rasy i typu konstytucyjnego oraz wieku. U noworodka wysokość głowy stanowi ¼ całej długości ciała. W miarę wzrastania zwiększa się długość tułowia i kończyn.

Tabela 3.3. Proporcje poszczególnych części ciała i zasady pomiaru

CZĘŚCI CIAŁA	SPOSÓB POMIARU	PROPORCJE (W PROCENTACH)
Długość tułowia i głowy	od wierzchołka głowy do górnego brzegu spojenia łonowego	48–50
Wysokość głowy	od wierzchołka głowy do dolnego brzegu trzonu żuchwy w linii środkowej ciała	10–15
Długość tułowia	od wcięcia mostkowego do górnego brzegu spojenia łonowego	29–31
Długość kończyny górnej	od najbardziej wysuniętego bocznie brzegu wyrostka barkowego do wierzchołka środkowego palca ręki	43–45
Długość kończyny dolnej	od górnego brzegu spojenia łonowego do płaszczyzny poziomej, na której stoi badany	50–52

WZROST

Wysokość lub długość ciała stanowi odległość między szczytem głowy a powierzchnią podeszwową stóp ustawionych prostopadle do goleni przy maksymalnym wyprostowaniu.

Sposób pomiaru

Wzrost mierzy się za pomocą wzrostomierza umieszczonego przy wadze lekarskiej lub stabilnej poziomej platformy, na której badany staje, oraz ruchomej poziomej platformy, którą można oprzeć na szczycie głowy. Badany powinien być wyprostowany, jego stopy muszą dokładnie przylegać do podłoża, a plecy być zwrócone do podziałki na wzrostomierzu. Wskaźnik wzrostomierza opiera się na szczycie głowy.

- **Długości kończyn górnych** określa się, mierząc odległość od czubka palca środkowego jednej ręki do czubka palca środkowego drugiej ręki, przy zupełnym rozciągnięciu ramion w poziomie. U osób zdrowych odległość ta mierzona w poziomie równa się wzrostowi.

STAN ODŻYWIENIA

Stan odżywienia ocenia się na podstawie wyglądu chorego, np. nadmiernie nagromadzona tkanka tłuszczowa świadczy o otyłości lub nadwadze, twarz z zapadniętymi policzkami i zaznaczonymi kośćmi policzkowymi, zapadniętymi gałkami ocznymi może sugerować niedożywienie.

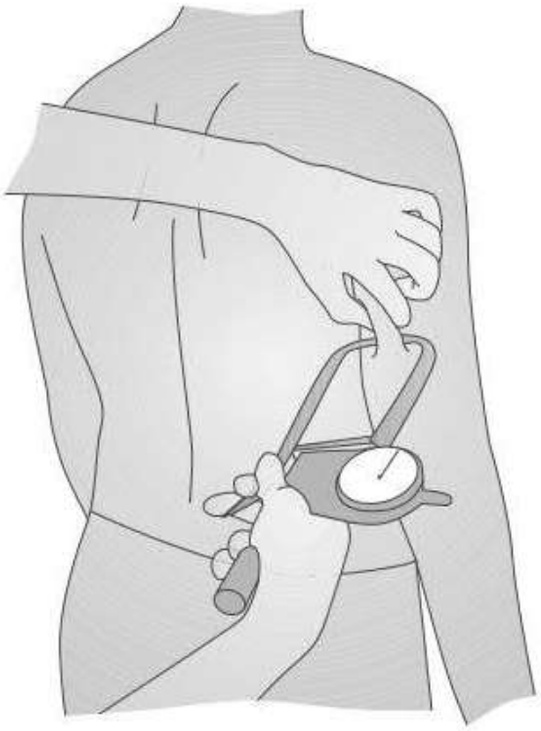
Ogólna masa ciała składa się z sumy mas czterech przestrzeni ciała: 50% masa komórkowa, 25% płyn pozakomórkowy, 7% masa minerałów i 18% masa tłuszczu.

Oceny stanu odżywienia dokonuje się na podstawie m.in. wartości takich parametrów, jak: masa ciała, grubość fałdu skórno-tłuszczowego, obwód ramienia.

Sposób pomiaru

- **Masę ciała** oznacza się u pacjenta, najlepiej rano, po oddaniu moczu oraz w lekkiej odzieży (piżamie), bez obuwia. Pomiaru powinno się dokonywać zawsze w ten sam sposób i najlepiej na tej samej wadze. Istnieją różne typy wag – do pomiaru w pozycji stojącej, siedzącej lub leżącej (wbudowane w łóżko).
- **Grubość fałdu skórno-tłuszczowego** mierzona jest nad mięśniem trójgłowym niedominującego ramienia u osoby siedzącej lub stojącej (ryc. 3.7).

Za pomocą taśmy centymetrowej mierzy się odległość między wierzchołkiem wyrostka łokciowego kości łokciowej a wierzchołkiem wyrostka barkowego łopatki, zaznaczając punkt znajdujący się nad mięśniem trójgłowym dokładnie w połowie długości między wymienionymi wyrostkami. Dwoma palcami należy delikatnie chwycić fałd skóry i tkanek podskórnych nad zaznaczonym wcześniej punktem i za pomocą specjalnego fałdomierza (kalipera) mierzy się trzykrotnie w odstępach kilkusekundowych grubość fałdu skórnego i oblicza wartość średnią.



Rycina 3.7. *Pomiar grubości fałdu skórno-tłuszczowego.*

- **Pomiar obwodu ramienia** wykonuje się w tym samym punkcie, w którym mierzony jest fałd skórny nad mięśniem trójgłowym. Pomiaru dokonuje się trzykrotnie i oblicza wartość średnią.

Dokumentacja wyników pomiaru

Uzyskane wartości pomiarów masy ciała odnosi się np. do wskaźnika masy ciała (body mass index – BMI). Jest to współczynnik otrzymany w wyniku podzielenia masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

$$\text{BMI} = \frac{\text{masa ciała}}{\text{wzrost} \times \text{wzrost}} = \frac{\text{masa ciała}}{\text{wzrost}^2}$$

Przykład: kobieta o wzroście 160 cm i masie ciała 58 kg ma

$$BMI = \frac{58}{1{,}6 \times 1{,}6} = 22{,}65$$

Wartość BMI dla osób dorosłych wskazuje na:

- niedowagę: < 18,5,
- wartość prawidłową: 18,5–24,9,
- nadwagę: 25,0–29,9,
- otyłość I°: 30,0–34,9,
- otyłość II°: 35,0–39,9,
- otyłość III°: ≥ 40,0.

3.3.3. PODSTAWOWE PARAMETRY ŻYCIOWE (ODDECH, TĘTNO, CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI, TEMPERATURA CIAŁA)

W skład oceny stanu ogólnego wchodzi również pomiar podstawowych parametrów życiowych, takich jak: oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi oraz temperatura ciała.

POMIAR ODDECHÓW

Pomiar oddechów wyznacza bardzo ważny parametr życiowy. Należy ocenić zarówno częstość oddechów (osoba dorosła oddycha z częstością 16–18 razy na minutę), jak i jakość oddychania. Prawidłowo oddech jest spokojny, u pacjenta nie występują objawy wzmożonego wysiłku związanego z nabieraniem powietrza podczas wdechu i wypuszczaniem podczas wydechu. Prawidłowy oddech powinien być bez zapachu.

Sposób pomiaru

- Liczbę oddechów należy mierzyć przez minutę, obserwując wychylenia klatki piersiowej. Jeden oddech to wykonanie wdechu i wydechu. Należy również sprawdzić, czy pacjent angażuje dodatkowe mięśnie oddechowe (np. mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe). W ocenie powinno się uwzględnić ruchy oddechowe, symetrię i kształt klatki piersiowej.

Dokumentacja wyników pomiaru

Tabela 3.4. Wyniki pomiaru oddechów

BADANY PARAMETR	WARTOŚĆ
Częstotliwość	prawidłowy u osoby dorosłej 16–18/minutę przyspieszony zwolniony brak oddechu (bezdech)
Rytm	miarowy niemiarowy
Amplituda	płytki głęboki nieregularny

POMIAR TĘTNA

Rozciągnięcie sprężystych tętnic pod wpływem rytmicznego wzrostu ciśnienia tętniczego nazywane jest **tętnem**. Tętno bada się najczęściej na obydwu tętnicach promieniowych, oceniając jego napięcie, częstość i miarowość. Innymi miejscami pomiaru tętna są: tętnice szyjne, tętnice ramienne, tętnice udowe i tętnice, które bada się w celu oceny krążenia obwodowego, tj. tętnice podkolanowe, piszczelowe tylne oraz grzbietowe stopy (patrz też rozdz. 8.2).

Prawidłowe tętno u osób dorosłych wynosi 1,17 Hz (70/min), **zakres** 55–115/min. Jest ono miarowe, dobrze wyczuwalne pod opuszkami palców, czyli prawidłowo napięte, i symetryczne, tzn. jednakowe np. na obu tętnicach promieniowych.

W warunkach prawidłowych wysokość tętna zależy od wieku, położenia ciała, pory dnia, wysiłku fizycznego i od przeżyć psychicznych. Podczas wysiłku, emocji, stresu obserwować można przyspieszoną czynność serca i tym samym przyspieszone tętno, natomiast zwolnione tętno w warunkach fizjologii może mieć miejsce np. podczas snu. Zwolnione tętno jest prawidłowe u sportowców.

Sposób pomiaru

- Potrzebny jest zegarek z sekundnikiem. Wzdłuż przebiegu tętnicy promieniowej układa się II, III i IV palec (zwykle prawej ręki). Częstość tętna mierzy się przez 15 sekund i mnoży wynik przez 4.
- W przypadku niemiarowości tętna należy oceniać jego częstość przez 60 sekund. Miarowość tętna oznacza regularność odkształcania się tętnicy pod wpływem fali krwi.

- Miarowość należy skonfrontować jednocześnie z czynnością serca (na koniuszku serca w V przestrzeń międzyżebrowej w linii środkowo-obojczykowej lewej).

Dokumentacja wyników pomiaru

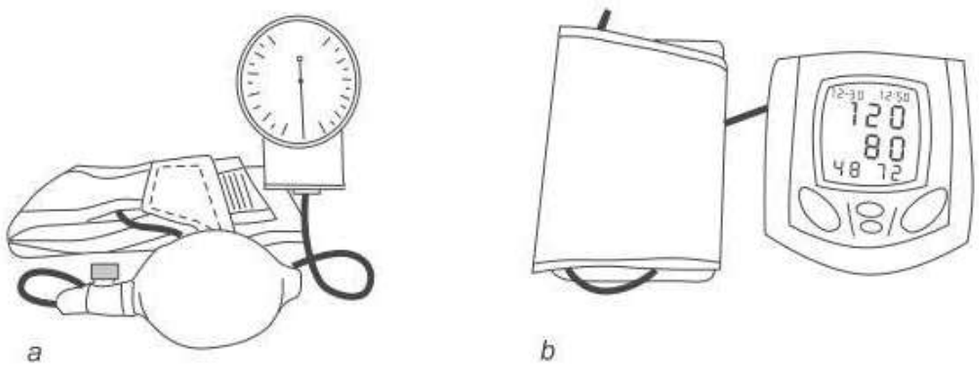
Tabela 3.5. Wyniki pomiaru tętna

BADANY PARAMETR	WARTOŚĆ
Częstotliwość	prawidłowe: 70/minutę zakres: 55–115/minutę
Siła tętna	0: nieobecne + 1: słabe + 2: normalne + 3: pełne

POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi (CTK) jest badaniem znanym już od ponad stu lat. Pierwszy aparat do pomiaru ciśnienia skonstruował włoski lekarz Riva-Rocci. On też opracował metodę pomiaru ciśnienia krwi z użyciem mankietu. Od pierwszych liter nazwiska jej twórcy wynik pomiaru określany jest jako **RR**.

Tradycyjnie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi można dokonać za pomocą osłuchiwania tonów – **metoda Korotkowa**, mierząc ciśnienie aparatem przy użyciu fonendoskopu (stetoskopu). Tony odzwierciedlają uderzenia fali krwi o ścianę naczynia krwionośnego; pojawiają się podczas wypuszczania powietrza z mankietu. Pierwszy słyszalny ton wyznacza ciśnienie skurczowe, ostatni odczytuje się jako ciśnienie rozkurczowe. Metoda jest dokładna, jednak jej precyzyjność w dużym stopniu zależy od umiejętności badającego.



Rycina 3.8. *Aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi: a – sprężynowy; b – elektroniczny.*

Zasady pomiaru

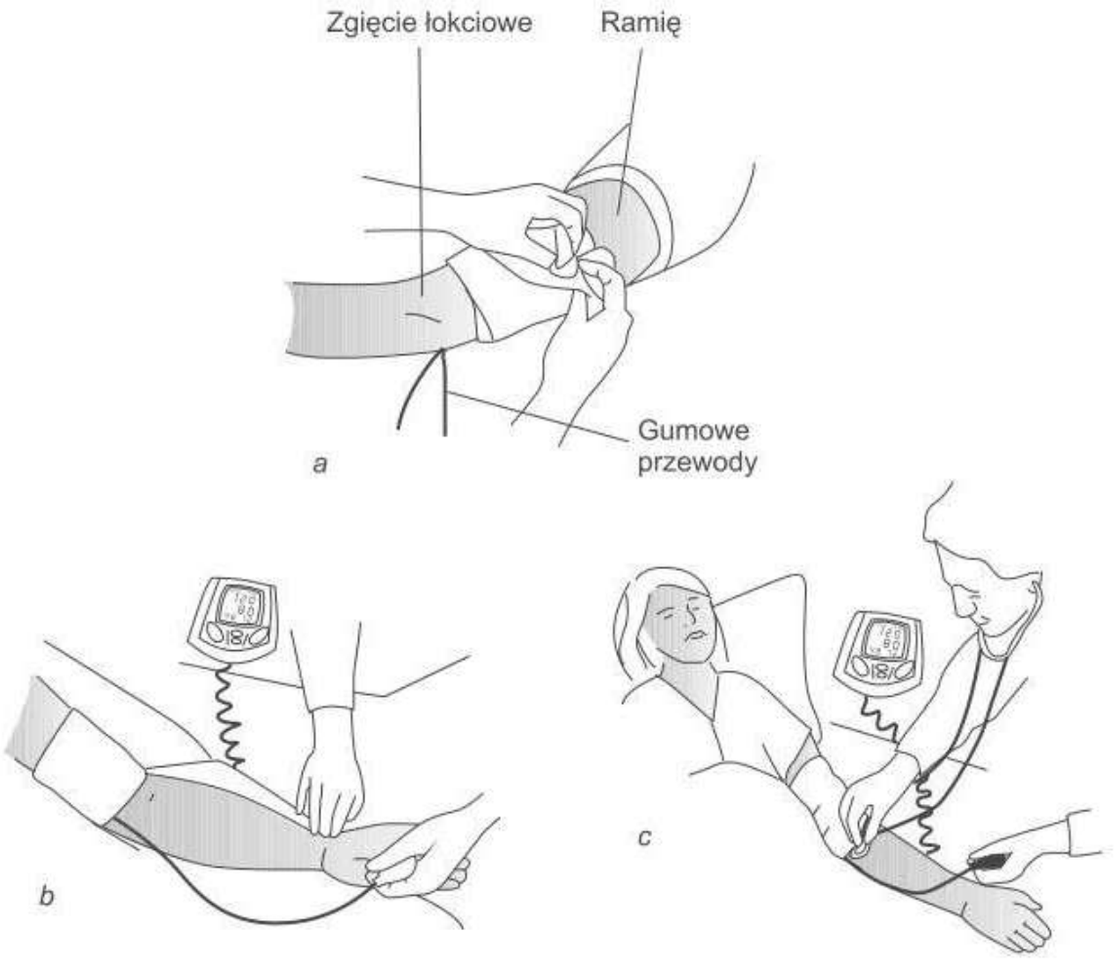
- Ze względu na to, że wartości ciśnienia tętniczego krwi zmieniają się wielokrotnie w ciągu doby, zwykle zalecane jest mierzenie ciśnienia o stałej porze, w tych samych warunkach, po przynajmniej 5 minutach spoczynku.
- Zaleca się również, aby przez co najmniej 30 minut przed pomiarem ciśnienia pacjent nie spożywał posiłków, nie pił kawy, mocnej herbaty oraz nie palił tytoniu.
- Podczas pomiaru ciśnienia badany powinien znajdować się w pozycji siedzącej lub leżącej.
- Najczęściej pomiaru dokonuje się na lewym lub prawym ramieniu (ramię powinno być odsłonięte).
- Opaskę ciśnieniomierza zakłada się tak, aby równo przylegała do ramienia i znajdowała się na wysokości serca.
- Jeśli mamy do dyspozycji aparat, w którym mankiet wyposażony jest w specjalny czujnik, to czujnik ten należy umieszczać w miejscu wyczuwalnego palcami tętna na tętnicy ramiennej.
- Szerokość mankietu stanowi 40% obwodu ramienia, długość – 80% obwodu ramienia; standardowa szerokość mankietu ciśnieniomierza wynosi 12–14 cm. Niewłaściwie dobrany mankiet może powodować zafałszowanie wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (za szeroki będzie powodował zawyżenie wartości ciśnienia, za wąski – zmniejszenie wartości ciśnienia).
- Po założeniu mankietu aparatu do pomiaru ciśnienia nie należy przez 3 minuty zmieniać pozycji ciała.
- U chorych z zaburzeniami rytmu serca wysokość ciśnienia ustala się z uśrednienia trzech pomiarów ciśnienia, przy czym między poszczególnymi pomiarami powietrze musi być wypuszczone z mankietu, na co najmniej 30 sekund.
- U osób z wyższym ciśnieniem tętniczym krwi na jednym z ramion przyjmuje się je za wyjściowe i kolejne pomiary ciśnień zawsze wykonuje na tym ramieniu.

Sposób pomiaru

- Przygotować sprawny sprzęt: aparat do pomiaru (szczelny mankiet, szczelna pompka i wężyki), czytelny zegar aparatu, fonendoskop.
- W czasie pomiaru ciśnienia pacjent powinien się znajdować w pozycji siedzącej lub leżącej.
- Najczęściej pomiaru dokonuje się na lewym lub prawym ramieniu (ramię powinno być odsłonięte).

- Po wyciśnięciu powietrza z mankietu ściśle przymocowuje się go do ramienia tak, aby część gumowa przykrywała co najmniej całą wewnętrzną połowę obwodu ramienia oraz aby dolny brzeg mankietu kończył się około 2,5 cm powyżej zgięcia łokciowego (ryc. 3.9).
- Mankiet musi ściśle przylegać do skóry ramienia, jednak nie może uciskać ani ramienia, ani naczyń krwionośnych, a w trakcie tłoczenia powietrza powinien się rozszerzać równomiernie, bez uwypukleń.
- **Opaskę ciśnieniomierza zakłada się tak, aby znajdowała się na wysokości serca.**
- Jeśli mamy do dyspozycji aparat, w którym mankiet wyposażony jest w specjalny czujnik, to czujnik ten należy umieszczać w miejscu wyczuwalnego palcami tętna na tętnicy ramiennej.
- Wyczuwając tętno na tętnicy promieniowej, należy napełniać mankiet powietrzem za pomocą pompki aż do momentu, kiedy zniknie tętno na tej tętnicy, następnie w wyniku pompowania szybko zwiększa się ciśnienie powietrza w mankiecie o wartość 30 mmHg.
- Do tętnicy ramiennej przykłada się membranę słuchawki i powoli z mankietu wypuszcza powietrze, nie szybciej niż 2–3 mm na sekundę.
- Z chwilą pojawienia się pierwszej fali tętna wysłuchuje się nad tętnicą ramienną ton, a odczytany w tym momencie stan słupka rtęci lub wartość na zegarze bądź też na skali cyfrowej manometru wskazuje wysokość ciśnienia skurczowego (jest to tzw. I faza Korotkowa).
- W miarę dalszego wypuszczania powietrza z mankietu słychać wyraźnie dźwięczne tony zwykle zgodne z czynnością serca, słyszalne aż do momentu, gdy głośność zmniejsza się, cichnie i znika. Wartość ciśnienia odczytana z manometru w chwili, gdy ton całkowicie zanika, wskazuje wysokość ciśnienia rozkurczowego (jest to tzw. V faza Korotkowa). Gdy tony są słyszalne aż do 0 mmHg, za ciśnienie rozkurczowe przyjmuje się wartość odpowiadającą ich ściszeniu (tzw. IV faza Korotkowa).

Jeśli badanie wykonywane jest po raz pierwszy, ciśnienie powinno się mierzyć na obu ramionach.



Rycina 3.9 *a–c. Etapy badania ciśnienia tętniczego krwi.*

Najczęściej popełniane błędy podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi:

- Mankiet zbyt wąski – podwyższa ciśnienie.
- Mankiet za szeroki – obniża ciśnienie.
- Zbyt mocne założenie mankietu – uzyskanie wartości zaniżonych (obniża ciśnienie skurczowe).
- Zbyt luźne założenie mankietu – uzyskanie wartości większych od rzeczywistych (podwyższa ciśnienie skurczowe).
- Ucisk ubrania powyżej mankietu – obniża ciśnienie rozkurczowe.
- Zaokrąglanie wyniku pomiaru do pełnych cyfr (5 lub 10) – należy zapisywać faktyczny wynik, np. 127/82 mmHg.

Dokumentacja wyników pomiaru

Tabela 3.6. Wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

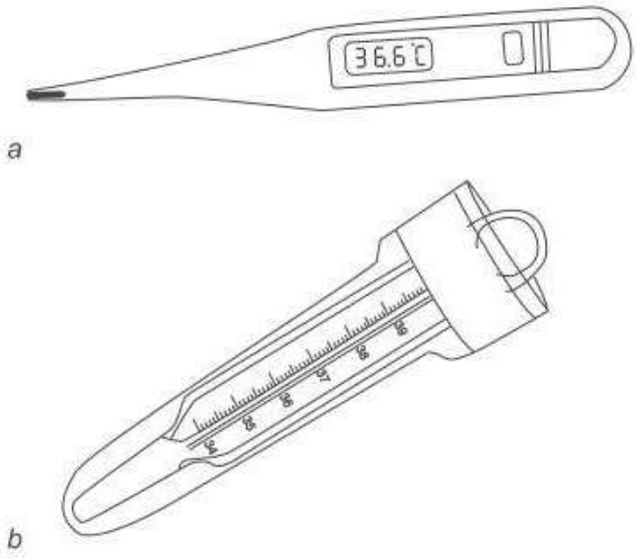
CIŚNIENIE TĘTNICZE KRWI	WARTOŚĆ
Optymalne	ciśnienie skurczowe < 120 mmHg ciśnienie rozkurczowe < 80 mmHg
Prawidłowe	ciśnienie skurczowe 120–129 mmHg ciśnienie rozkurczowe 80–84 mmHg
Wysokie prawidłowe	ciśnienie skurczowe 130–139 mmHg ciśnienie rozkurczowe 85–89 mmHg
Amplituda	30–50 mmHg

POMIAR TEMPERATURY CIAŁA

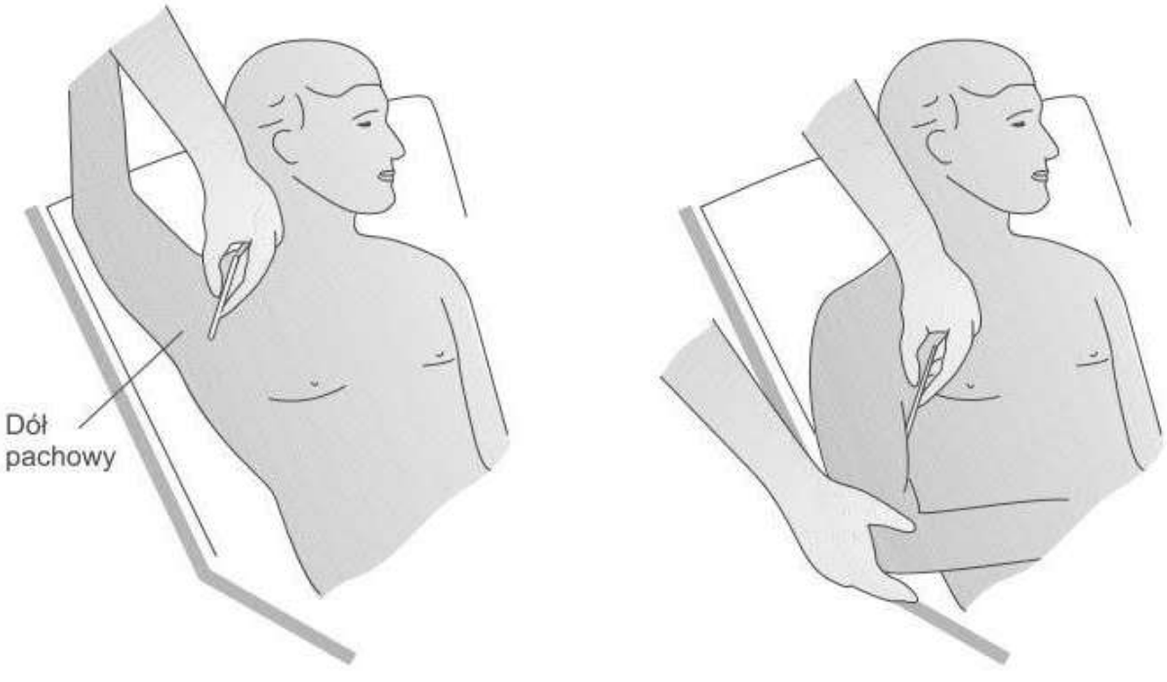
Główną rolę w regulacji temperatury ciała odgrywają ośrodki nerwowe podwzgórza. Prawidłowa temperatura ciała (mierzona pod pachą) wynosi 36–37°C. Różnica między temperaturą poranną a wieczorną na ogół nie przekracza 0,5°C.

Sposób pomiaru

- Temperaturę ciała ocenia się co najmniej dwa razy dziennie (rano przed południem i około godziny 16:00). Pomiaru nie należy dokonywać bezpośrednio po spacerze, kąpieli, nasłonecznieniu, naświetleniu i w stanie zwiększonego zdenerwowania.
- Przed pomiarem termometr trzeba oczyścić zgodnie z przyjętymi zasadami, osuszyć i sprawdzić prawidłowe jego działanie, aby uniknąć błędu pomiaru.
- Obecnie do pomiaru temperatury wykorzystywane są termometry elektroniczne, które mogą mieć specjalne nakładki służące do pomiaru temperatury w przewodzie słuchowym zewnętrznym.
- Przed pomiarem ciepłoty ciała należy przygotować odpowiedni termometr w zależności od preferowanego miejsca pomiaru oraz jeśli pomiar będzie wykonywany pod pachą, osuszyć skórę.
- Trzeba wyjaśnić pacjentowi, ile czasu będzie trwał pomiar, aby wynik był miarodajny, oraz jaką powinien przyjąć pozycję najwygodniejszą w czasie pomiaru temperatury (przy pomiarze temperatury w odbycie odpowiednia będzie pozycja na boku ze zgiętymi lekko kończynami dolnymi w stawach kolanowych).
- Z osobami, które nie są w stanie samodzielnie dokonać pomiaru, należy być przez cały czas jego trwania.



Rycina 3.10. *Termometry: a – elektroniczny; b – z osłonką.*



Rycina 3.11. *Pomiar temperatury ciała pod pachą.*

Dokumentacja wyników pomiaru

Tabela 3.7. Wyniki pomiaru temperatury ciała

TEMPERATURA CIAŁA	WARTOŚĆ
Prawidłowa	mierzona pod pachą 36–37°C
Niedocieplność	poniżej 36°C
Nadcieplność	powyżej 37°C
Gorączka	38°C i więcej